

4장 임신여성의 산전관리

● 학습목표

- 임신기간 동안 요구되는 산전간호 일정을 설명한다.
- 첫 산전간호 방문 시 사정해야 할 내용을 서술한다.
- 추후 산전간호 방문 시 사정해야 할 내용을 서술한다.
- 임신 각 기(1기, 2기, 3기)별 간호계획을 세운다.
- 임부의 건강과 안위증진을 위한 간호를 한다.

● 주요 목차

1. 산전관리의 목적
2. 건강사정
 - 임신력과 출산력
 - 첫 산전방문
 - 추후 산전방문
 - 임부의 사회심리적 건강사정
3. 간호진단과 중재
 - 산전관리
 - 건강증진 및 유지
 - 임신 동안의 영양관리
 - 임신 중 경증 불편감

● 주요 용어

경증 불편감	minor discomfort
골반저근운동	pelvic floor muscle exercise
골반흔들기	pelvic rocking
네겔 법칙	Nagele's rule
레오폴드 복부촉진법	Leopold's maneuver
마지막 월경일	last menstrual period, LMP
분만예정일	estimated date of confinement, EDC
산부	para
산전간호	antepartal care
양와위성 저혈압	supine hypotension
임부	gravida
임신력	gravidity
자궁저부 높이	height of fundus
출산력	parity
태동	quickening
태아심음	fetal heart tone, FHT
Pap 도말검사	Papanicolau(Pap) smear

임부와 태아의 건강을 가장 안전하게 유지하는 방법은 임부가 산전관리를 건강하게 하는 것이다. 임신기간은 계속적으로 모체와 태아의 건강에 주의를 기울여야 하는 중요한 시기이므로 정기적인 산전간호가 필요하다. 산전간호는 모체와 태아의 안녕과 건강을 목적으로 행해져야 하며 산전방문 시 신체적, 사회심리적으로 임부를 사정하고 임부 및 태아 건강, 임부 영양, 임신 중 경증의 불편감에 대하여 임부 및 가족들에게 적절한 교육과 상담을 하여 임부의 건강증진과 태아의 안녕상태가 유지되어야 한다. 간호사는 임부 및 가족들과 긍정적 신뢰 관계를 형성하며 임신 중 지켜야 할 여러 가지 문제들에 관해 상담과 교육을 해야 한다.

1. 산전관리의 목적

임신은 정상적인 생리과정이지만 신체적, 정신적, 사회적으로 많은 변화가 나타나는 시기이다. 임부와 태아의 건강을 안전하게 유지하는 가장 좋은 방법은 정기적인 산전관리이다. 간호사는 산전관리에서 특히 간호사 정의 중요한 역할을 담당한다. 임신기간은 계속적으로 건강에 주의를 기울여야 하는 중요한 시기이므로 정기적인 산전방문은 마지막 월경기간 직후에 시작하는 것이 이상적이며, 정상적인 임신과정을 관리하고, 임부와 가족을 위한 임신적응을 돕는다. 최근 산전관리는 태아와 신생아의 고위험상황 확인 및 관리에 많은 관심을 두고 있다. 산전관리는 임부의 건강과 건강한 신생아 출생 이외에 임신 중 가족건강과 출생 후의 영아 건강 관리까지 적용된다.

(1) 임부를 위한 산전관리 목적

- 임신 전, 임신 중 및 분만 이후 임부의 안녕 유지, 및 자가간호를 증진한다.
- 모성 사망률과 이환율, 태아 사망과 같은 불필요한 임신 소모가 감소한다.
- 다음 임신 및 가임연령 이후의 건강 위험요인이 감소한다.
- 임부의 고위험상태를 선별(sceening)한다.

- 부모가 되기 위한 마음가짐 및 기술을 교육한다.

(2) 태아를 위한 산전관리 목적

- 태아의 안녕을 유지하고 건강을 증진한다.
- 조산, 자궁 내 성장 지연, 선천성 기형 및 사망이 감소한다.
- 신경발달장애 및 기타 질병이환율이 감소한다.
- 정상적인 성장발달과 건강관리를 증진한다.
- 출생 후 어린이 학대, 손상, 예방 가능한 급만성질환 및 출생 후 입원치료의 가능성이 감소한다.

(3) 가족을 위한 산전관리 목적

- 원하지 않는 임신이 감소한다.
- 자녀양육에 대한 태만과 가정폭력을 일으킬 수 있는 가족의 행동장애가 감소한다.
- 가족발달과 부모-자녀 간 상호작용을 증진한다.

2. 건강사정

1) 임신력과 출산력

임신력과 출산력을 기록하는 두 가지 방법이 있다. 첫 번째 기록방법은 신생아의 생존력과 관계없이 임신과 출산의 횟수를 요약해서 쓰는 임신력(gravidity)/출산

표 4-I-17. 임신력과 출산력 관련 용어

- 산전(antepartum) : 임신과 분만 직전의 기간, 보통 임부의 임신기간을 의미
- 분만(intrapartum) : 태아 출산과 태반 만출 때까지의 분만시기
- 산후(postpartum) : 임신 전 상태로 회복되기까지의 기간
- 재태기간(gestation) : 마지막 월경일(LMP)부터 임신 주수
- 유산(abortion) : 임신 20주 이전 또는 신생아 몸무게 500g 이하 출산
- 만삭(fullterm) : 37주에서 41주까지의 정상적인 임신기간
- 조기분만(preterm or premature labor) : 20주 이후에서 37주 이전의 출산
- 과숙분만(postterm labor) : 42주 이후 출산
- 임부(gravida) : 현재 임신을 포함하여 임신기간에 상관없이 임신한 경험이 있는 여성
- 미임부(nulligravida) : 임신한 경험이 없는 여성
- 초임부(primigravida) : 처음 임신한 여성
- 경임부(multigravida) : 두 번째 혹은 여러 번 임신한 여성
- 산부(para) : 신생아의 생존 유무에 상관없이 20주 이후 분만 경험이 있는 여성
- 미산부(nullipara) : 20주 이후 분만 경험이 없는 여성
- 초산모(primipara) : 신생아의 생존 유무에 상관없이 20주 이후 분만 경험이 처음인 여성
- 경산모(multipara) : 임신 20주 이후 두 번째 이상 분만 경험이 있는 여성
- 사산(stillbirth) : 임신 20주 이후 사망한 태아 출산

표 4-I-18. 4자리 숫자체계와 5자리 숫자체계

- G (gravida) : 출산과 관계없이 현재 임신을 포함한 총 임신 수
- T (term birth) : 37주 이후 만삭분만(term birth)의 수
- P (preterm birth) : 20주 이후에서 37주 사이의 조산(preterm birth)의 수
- A (abortion) : 자연유산 또는 치료적 유산과 상관없는 유산(abortion)의 수
- L (living child) : 현재 살아 있는 아이(living child)의 수

력(parity)을 사용한다. 이 방법에서 예를 들어 1/0은 처음 임신한 여성(primigravida)으로 아이를 한 번도 분만해보지 않은 경우인 미산부(nullipara)를 뜻한다.

두 번째 기록방법은 숫자체계를 사용한다. 출산력은 신생아의 생존력에 상관없이 분만 경험을 의미하며, 임신력은 현재 자궁 내 상태를 포함한 임신 경험을 말한다. 임상에서는 4자리 숫자체계(총 만삭분만 수-조산 수-유산 수-현재 살아 있는 아이의 수)와 현재 임신을 포함한 5자리 숫자체계(총 임신횟수-총 만삭분만 수-조산 수-유산 수-현재 살아 있는 아이의 수)를 이용하여 기록한다(표 4-I-18).

출산 수에서 1회 분만에서 둘 이상의 아기를 출산하

여도 한 번으로 계산하며, 임신력에는 현재 임신도 포함한다.

두 가지 기록방법을 이용한 예를 정리해보면 다음과 같다(표 4-I-19).

- 이씨 부인은 현재 임신 12주로 산전방문을 하였으며, 38주에 첫 분만을 하였고, 28주에 사산을 하였다. G3/P2로 기록하거나 숫자체계를 이용하여 3-1-1-0-1로 기록한다.
- 김씨 부인은 첫 임신은 15주에 자연유산을 하였으며, 두 번째 임신은 40주에 딸을 출산하였다. 세 번째 임신은 32주에 건강한 쌍둥이를 출산하였으며, 네 번째 임신은 38주에 분만하였지만 사망하였다.

표 4-I-19. 숫자체계를 이용한 기록

사례	총 임신수(G)	총 만삭분만 수(T)	조산 수(P)	유산 수(A)	살아 있는 자녀 수(L)
이씨 부인	3	1	1	0	1
김씨 부인	4	2	1	1	3

G4/P3로 기록하거나 숫자체계를 이용하여 4-2-1-1-3로 기록한다.

2) 첫 산전방문

첫 산전방문에서는 임신 여부를 확인한다. 인구학적 정보, 산과력, 월경력, 가족력, 과거력 등을 포함한 종합적인 건강력을 조사한다.

(1) 건강력

건강력을 확인하는 가장 중요한 목적은 임신상태를 진단하며, 임신에 영향을 주는 중요한 건강요인을 확인하기 위함이다. 건강력에는 인구학적 정보, 산과력, 현 임신력, 생식기 병력, 과거 병력, 가족력, 성생활에 관한 정보가 포함된다. 따라서, 간호사는 최선의 산전간호를 위해서 신뢰관계를 형성하기 위한 대화술의 원칙을 지키면서 가급적 임부의 표현 그대로를 이용하여 정확하게 기록한다.

① 인구학적 정보

인구학적 정보는 연령, 주소, 교육수준, 인종, 주거형태, 경제적 수준, 종교, 결혼상태, 직업, 지지체계, 임신과 출산에 대한 개인적 선호도, 다음 자녀 양육계획, 수유형태 선호도(모유수유, 인공수유) 등이 포함된다.

② 산과력

- 임신력 및 출산력 : 임신과 출산에 관하여 다섯 가지 숫자체계를 이용하여 표시한다.
- 이전 임신에 관한 구체적인 내용 : 임신 주수, 분만

장소, 분만에 걸린 시간, 분만형태(질식 분만, 겸자 분만, 흡입분만, 제왕절개분만), 마취를 사용했다면 마취형태, 임신 동안 내과적 또는 산과적 합병증

- 출생아의 상태 : 아파가 점수, 출생 시 체중 및 성별, 합병증, 전반적인 발달상태, 수유형태(모유수유, 인공수유), 출생아의 건강상태
- 자녀 상실 경험(자연유산, 치료적 유산, 사산, 신생아 사망 등) : 자녀를 상실했을 때의 감정, 대처기술, 배우자의 반응
- 혈액형과 Rh 형태 : 만약 Rh-인 경우, 분만 후 동종면역감작을 예방하기 위한 투약 경험
- 산전 분만교육 경험, 교육자료(책 등)

③ 현 임신력

• 분만 예정일 추정

분만 예정일 계산은 마지막 월경 첫날(LMP)을 알고 있어야 도움이 된다. 가장 흔한 분만 예정일 계산방법은 네겔 법칙(Nagele's rule)을 이용한다(표 4-I-20). 또 다른 방법은 재태월령 계산 도구를 이용하여 더 신속하

표 4-I-20. 네겔 법칙에 의한 분만예정일 계산

마지막 월경 첫날을 이용하여 계산하는데,
 월(month) 일(day)
 -3(그 다음해), + 7
 + 9
 = 분만 예정일

예를 들면, 마지막 월경일 2015년 7월 15일
 -3, + 7
 = 2016년 4월 22일

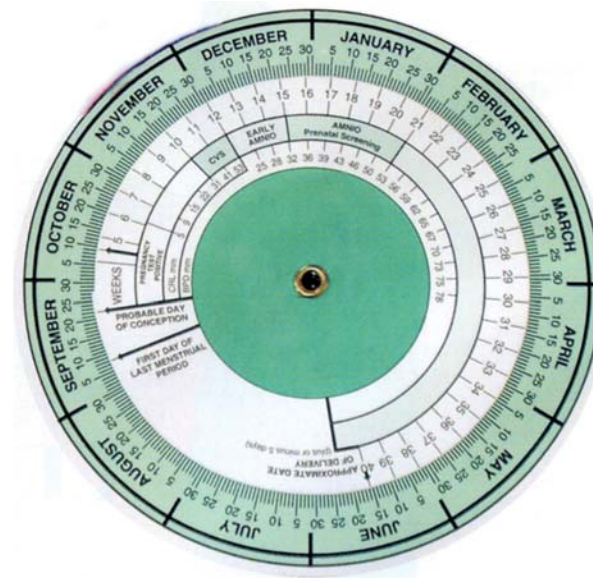


그림 4-I-27. 재태월령 계산도구(EDB wheel)

게 계산할 수 있다(그림 4-I-27). 마지막 월경일(LMP)을 정확히 기억하는 28일형 월경주기라면 네겔 법칙은 분만 예정일을 정확히 계산하는 방법이 될 수 있다. 그러나 35일 월경주기나 40일 월경주기 또는 불규칙한 월경주기라면 배란시기가 7일 정도 늦춰질 수 있다. 보통 배란주기는 이전 월경주기 14일 이후가 아니라 다음 월경주기 14일 전이 배란시기이다.

월경주기가 불규칙한 경우라면, 자궁저부 높이, 태동 시작시기, 초음파를 이용한 검사, 태아심을 청진 등을 이용하여 추정할 수 있다.

• 합병증 사정

합병증을 알기 위해 두통, 현기증, 시력장애, 열, 피로, 오심 및 구토, 가슴앓이, 유방 변화, 가쁜 호흡, 요통, 복통, 질 출혈, 정맥류, 부종, 백대하 등의 유무를 파악하고 만일 호소하는 내용이 있으면 다음 내용을 확인해야 한다.

- 임신 동안 증상이 일어난 시기, 기간, 재발의 유무
- 동반된 다른 증상

- 증상이 나타난 부위 및 정도
- 의학적 치료 여부
- 증상에 영향을 미치는 요인
- 증상을 치료하거나 완화하는 방법 및 그 효과에 관한 내용

④ 생식기 병력

- Pap 도말검사 : 검사시기, 비정상적인 결과
- 이전 감염 : 질염, 자궁경부염, 성전파성 질환 감염 등
- 이전 수술 경험
- 월경력 : 초경연령, 월경의 빈도 및 기간, 월경량, 월경양상, 최종 월경일, 월경곤란증, 부정출혈, 월경전 증후군(premenstrual syndrome)
- 성생활 : 성교의 빈도 및 만족도, 성교 시 불편감, 성교 후 출혈 등
- 피임법 : 과거 사용하였던 피임법의 종류 및 기간, 각 피임법에 대한 부작용, 피임법을 중단한 이유 및 시기 등, 만약 출산계획을 위해 피임을 사용했다면 피임 중단 후 임신이 바로 되었는지, 그렇지 않다면 얼마나 기간이 걸렸는지

⑤ 과거병력

- 아동기 병력 : 홍역, 백일해 등
- 주요 질병 및 입원 경험 : 폐렴, 간염, 류마티스열, 신우신염, 암 등
- 수술 경험 및 수혈 경험
- 사고 : 골절, 무의식 등
- 알레르기 : 음식, 환경, 천식, 약물 등
- 약물 남용 및 알코올중독

⑥ 가족력

- 부모의 생존 여부, 연령, 사망한 경우 그 원인, 부모와 부모 형제 중에 암, 심혈관질환, 고혈압, 당뇨병,

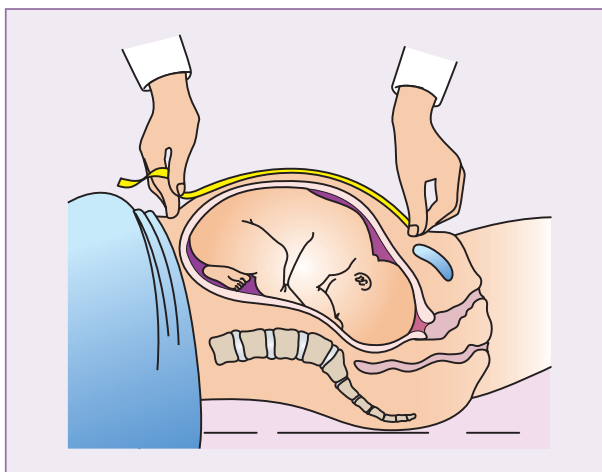


그림 4-I-28. McDonald's method

혈액학적 장애, 결핵, 간질, 알레르기, 다태임신 경향, 선천성 기형 병력, 제왕절개술 병력 등

(2) 신체검진

① 자궁저부 높이(height of fundus)

자궁저부 높이는 자궁의 크기를 사정하는 지표이므로 매 방문 시마다 측정한다. 측정방법은 줄자를 이용하여 치골결합 상부에서 복부 중앙선을 따라 복부의 모양대로 둥글게 하여 자궁저부까지의 길이를 잰다(McDonald's method)(그림 4-I-28).

자궁저부 높이 측정은 22주에서 34주 사이에는 자궁의 크기를 측정하는 정확한 방법이다. 예를 들어, 26주의 자궁저부 높이는 26cm이며, 보통 $\pm 2\text{cm}$ 를 고려한다. 정확한 검사를 위해, 같은 시기에 같은 줄자를 이용하며, 검사 전 방광을 비우고, 상체는 약간 올리고, 무릎을 굽힌 자세로 자궁저부 높이를 측정한다. 임신 3기에는 자궁저부 높이가 정확하지 않을 수 있다. 또 다음과 같은 상황에서는 더욱 부정확할 수 있다.

- 비만여성(정확한 자궁저부 측진이 어렵기 때문)
- 자궁근종이 있는 여성(자궁의 크기가 왜곡되기 때문)
- 양수과다증 여성(양수로 인해 자궁 크기가 증가하

기 때문)

자궁저부 높이는 다른 정보를 의미할 수 있다. 예를 들어, 자궁저부 높이의 감소는 자궁 내 성장 지연(intrauterine growth restriction, IUGR), 갑작스러운 증가는 다태임신이나 양수과다증을 의미한다.

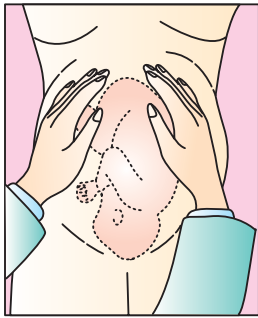
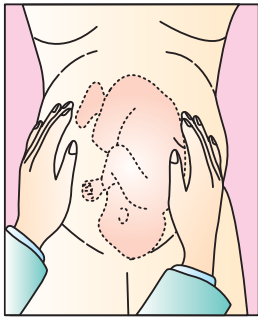
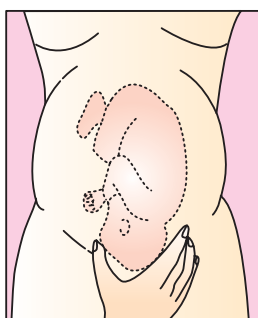
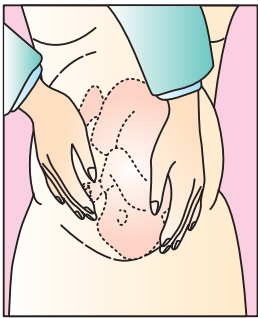
② 복위

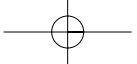
임신 34주 이후 비정상상을 가려내기 위해 시행하는 방법으로, 자궁의 크기가 너무 크다고 의심될 때, 즉 다태임신, 양수과다증을 진단할 때 유용하다. 측정방법은 배꼽을 중심으로 복부 둘레를 재는데, 일반적으로 임신 주수보다 2인치 정도 작다. 예를 들면 임신 34주에 32인치(약 81cm), 36주에 34인치(약 86cm), 38주에 36인치(약 91cm), 40주에 38인치(약 96.5cm)로 추정할 수 있다. 일반적으로 임신 주수와 관계없이 100cm 이상이면 자궁의 크기가 비정상적으로 큰 것으로 생각하며 더 세밀한 관찰이 필요하다. 비대한 여성인 경우에는 이 기준이 합당하지 않으므로, 임신 34주 이전에 복위를 측정하여 기준치를 구하고, 임신이 진행됨에 따라 평가하며 필요한 경우 초음파 등의 보조검사를 시행한다.

③ 레오폴드 복부촉진법

복부에 손을 대기 전에 복부의 형태, 색소침착, 복부의 부종 유무, 복부의 크기 등을 눈으로 확인한 다음 복부를 촉진하여 태향, 태위를 확인한다. 간호사는 레오폴드 복부촉진법에 의한 4단계 방법을 체계적으로 수행할 수 있어야 한다. 먼저 임부의 방광을 비워야 한다. 이는 임부를 편안하게 하며 좀 더 정확한 결과를 얻을 수 있다. 검사하는 동안 임부는 등을 대고 똑바로 누워 무릎을 구부리고 복부근육을 이완시킨다. 간호사는 두 손바닥 전체를 이용하여 손가락을 꼭 붙이고 부드럽고 깊게 압력을 가하면서 촉진한다. 만약 간호사의 두 손이 차가우면 복부의 근육이 수축하므로 손을 따뜻하게 한

표 4-I-21. 레오폴드 복부촉진법(Leopold maneuver)

단계	촉진 방법	촉진 결과	결과의 의미
1단계	 • 시술자는 임부의 머리 쪽을 본다. • 자궁저부에 양손을 두고 손가락을 구부려 촉진 • 태위(종위, 횡위)와 선진부(두부, 둔부)를 확인	• 태아 부분이 둥글고 단단하게 만져지며 움직인다. 두 손 사이나 한 손의 엄지와 시지 사이에 부구감(ballottement)이 있다. • 태아가 불규칙하게 만져지고 크거나 두드러지게 튀어 나온 부분이 느껴지며, 머리보다는 덜 단단하게 만져진다. • 상기 어느 것도 아니다.	• 태아의 머리 부분이며 몸체와 독립적으로 움직이며, 종위(longitudinal lie)이다. • 태아의 둔부이며 몸체와 독립적으로 움직이지 못하며, 종위(longitudinal lie)이다. • 횡위(transverse lie)이다.
2단계	 • 시술자는 계속 임부의 머리 쪽을 본다. • 치골결합과 자궁저부 사이 자궁의 양 측면을 촉진 • 좌, 우 등 어느 한쪽 손에 압력을 가하여 복부의 반대쪽으로 태아를 밀어 부분을 촉진하고 다시 반대로 한다.	• 단단하고 두드러진 덩어리나 계속적으로 완만한 저항이 있는 덩어리가 촉진된다. • 작고 불규칙한 움직이는 덩어리가 있고 검사자의 손가락을 차거나 칠 수 있다. • 복부 전면에 작은 덩어리가 만져지고 태아의 등을 만지기 어렵다.	• 태아의 등이 만져지는 것이며 등이 임부의 좌우 어느 쪽에 있는지에 따라 태위가 결정된다. 종위(longitudinal lie)이다. • 태아의 소부분으로 지적되며 태아의 손, 다리, 무릎, 팔꿈치이다. 태아의 등이 있는 반대편이 된다. • 후위(posterior position)이다.
3단계	 • 시술자는 계속 임부의 머리 쪽을 본다. • 치골결합 상부인 하복부 촉진하여 골반 진입과 태세 확인 • 선진부가 골반 진입이 안 된 경우에는 움직이는 덩어리 촉진 • 둔부인지 머리인지 감별하기 위해 1단계처럼 모양 크기, 강도, 운동을 촉진	• 선진부가 머리인 경우 진입(engagement)현상이 일어났을 때는 쉽게 움직이지 않는다. • 진입이 안 된 경우에는 1단계처럼 쉽게 움직이고 부구감이 있다.	• 1단계와 3단계의 결과를 비교하여 태위(lie)와 태향(pre-sentation)을 결정 • Pawlik's maneuver : 한 손은 자궁저부에 두고 다른 한 손은 치골결합부에 두어 동시에 자궁의 양쪽 극을 촉진하여 태아의 어느 부분인지를 파악하는 방법이다.
4단계	 • 시술자는 몸을 돌려 임부의 발을 향하여 선다. • 두 손을 이용하여 치골결합을 향해 깊이 촉진하면서 하강 정도와 아두 상태를 측정한다. • 태아 머리의 돌출부(cephalic prominence) 촉진 후에는 골반강을 더 촉진하지 않는다.	• 머리가 선진부라면 한 손은 등근 돌출부위를 만지고 다른 한 손은 골반강을 향해 그대로 평이하게 내려간다.	• 태아 머리의 돌출부가 태아의 등과 같은 쪽에 있으면 태아 머리가 신전(extension)된 안면위(face presentation)이다. 돌출부가 태아의 등과 서로 반대로 위치하면 태아 머리가 굴곡(flexion)된 두정위(vertex presentation)이다.



후 촉진한다(표 4-I-21).

④ 질검사

질검사는 아두의 천문과 봉합선을 알아내기 위한 검사이다. 임신 시에는 자궁경부가 닫혀 있기 때문에 질검사로 태향을 알아내지 못하며, 분만 도중이나 경부가 완전히 확장된 후에야 태향과 아두의 굴곡 정도를 알 수 있다.

⑤ 골반검사

골반검사는 외부 및 내부 생식기와 골반형태에 대한 사진 및 촉진을 하기 위한 것이다.

• 질경검사

질과 경부 점액의 특성을 검사하는 것으로 적당한 크기의 질경을 따뜻한 물로 적셔서 질에 삽입하고, 질과 경부를 시진한다. 특별한 검사를 하고자 할 때는 윤활제를 사용하지 않는다. 자궁경부와 질을 시진하여 색깔, 위치, 궤양, 결절, 종양, 출혈, 분비물 등을 관찰한다. 또한, 배양검사를 위한 분비물을 채취한다.

-대상자에게 배뇨하도록 한다.

-사용할 기구를 준비한다. 질경(speculum)은 삽입하기 전에 따뜻하게 해둔다.

-대상자에게 쇄석위(lithotomy position)를 취하게 하고 앞으로 할 과정을 설명한다.

-임부가 호흡을 조절하여 편안히 이완할 수 있도록 한다.

질경을 삽입하기 전과 질검사를 할 때는 대화를 하여 주의를 딴 곳으로 쏠리게 한다.

• 양손 진찰법

검진자는 소독장갑을 끼고 시지와 장지를 질에 삽입하여 후벽 쪽으로 힘을 주어 내부 생식기를 촉진한다. 요도

나 방광 전벽, 질벽 등에 결절이 있는지 통증과민성이 있는지 살핀다. 자궁경부의 위치, 모양, 경도, 규칙성, 운동성 및 통증과민성 등을 확인한다. 자궁경부 주위의 질원개(fornix)를 촉진한다. 복부에 올려 놓은 손을 제와부와 치골 부위 사이에 놓고 질 내에 들어 있는 손을 향해 아래로 힘을 준다. 양손 사이에 있는 자궁의 크기, 모양, 강도, 운동성, 통증과민성 및 종양 등을 확인해야 한다. 또한, 난소와 부속기를 확인할 수 있다. 난소는 약간의 통증과민성을 나타낸다. 검사가 끝나면 검사 중 사용한 윤활제를 따뜻한 물수건을 이용하여 닦아주고 임부가 검사대에서 몸을 일으키고 앉도록 도와준다.

(3) 검사실 검사

임신 중 다양한 임상검사를 실시하여 모체의 건강상태와 태아의 건강상태를 사정하게 된다(표 4-I-22).

① 소변검사

• 목적 : 첫 방문과 정기적인 방문 시에 포도당과 단백질의 유무를 확인하기 위한 것이다.

• 과정 : 검사물은 아침에 처음 배뇨에서 얻는 것이 이상적이다. 깨끗한 용기를 이용하여 중간배뇨를 다음과 같은 방법으로 받는다.

-음순을 벌리고 화장지를 적셔서 앞에서 뒤쪽으로 닦는다.

-배뇨를 시작한 뒤 중간쯤에 깨끗한 용기에 받는다. 30~60ml 정도면 충분하다.

-검사하기 위해 소변을 검사실로 보낸다.

② 혈액검사

혈액검사는 혈색소(Hb), 혈액형, 매독, Rh 유형 등을 보기 위한 것이며, 특히 매독은 조기에 발견해서 가능한 한 빨리 치료함으로써 기형이나 사산 등을 예방하도록 한다.

표 4-I-22. 우리나라 산부인과에서 권장하는 산전관리

임신 주수	검사 항목
최초 방문 시	초음파, 빈혈검사, 혈액형검사, 풍진항체검사, B형 간염검사, AIDS 검사, 소변검사, Pap 도말검사
9~13	초음파(목덜미 투명대 nuchal translucency), 용모생검, 이중 표지물질검사
15~20	사중 표지물질검사, 양수검사
20~24	임신 중기 초음파, 태아 심장 초음파
24~28	임신성 당뇨 선별검사, 빈혈검사
28	Rh 음성인 경우 면역글로불린 주사
32~36	초음파검사(태아체중, 태반위치, 양수량)

* 28주까지 4주마다, 임신 36주까지 2주마다, 그 후 1주마다 정기진찰, 고위험 임신이면 1주일에 2회 진찰이 필요하기도 함.

• 혈액형의 중요성

ABO나 Rh 유형을 파악하기 위하여 시행한다. ABO 부적합증과 Rh 부적합증은 산과적으로 중요한 문제가 되는데 이는 모체에 항체가 생겨 태아에게 이 항체가 옮겨져 적혈구를 파괴시키는 용혈성 빈혈을 유발하기 때문이다. ABO 부적합증에서는 수혈을 할 때 혈액을 주는 자(donor)와 받는 자(receiver)의 혈액이 맞지 않으면 용혈작용이 일어나게 되므로, 임부는 산전 진찰을 통해서 미리 혈액형과 항체관계를 알아두는 것이 좋다. 태아가 어머니와 다른 혈액형인 경우 모체의 혈액 내에서 항체가 생겨 이것이 태반혈류를 통해 태아에게 전달된 뒤 태아적아구증(erythroblastosis)과 같은 증세를 나타낸다. 이를 ABO 부적합증이라고 하며, 그렇게 흔하지는 않다. ABO 부적합증에 의한 태아적아구증은 첫 임신 때부터 일어난다.

• Rh 부적합증

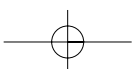
인간의 혈액 내에 Rh요인이 있다는 것을 발견한 것은 1949년이었으며, 그 이후 백인의 약 85%는 이 Rh요인을 갖고 있다는 사실을 알게 되었다. 동양인은 90%가 Rh+이며, 10%는 Rh-이다. 모체혈이 Rh요인이 없는 Rh-이면 남편의 혈액형을 조사하여야 한다. 남편이

Rh-이면 태아에게 문제가 생기지 않으나, 남편이 Rh요인이 있을 때(Rh+)는 태아의 혈액은 Rh+가 된다. 태반혈류를 통해서 태아의 Rh항원이 모체혈로 가게 되면 모체혈에 Rh항체가 생긴다. 이 항체가 태반을 통하여 태아순환으로 들어가면 태아의 적혈구를 파괴시키며, 모체혈에 이러한 항체가 다량으로 생길 때 태아적아구증(erythroblastosis)으로 태아가 사망할 수 있다. 임신 초기에 혈액형을 검사하여, 모체혈이 음성인 경우는 정기적으로 Rh 항체검사를 실시하여 만약 항체가 나타날 때는 즉시 유도분만(induction)을 하여 태아의 생명을 구할 수 있다. 대개의 경우 첫 아기는 위험하지 않으나 산후에 이 항체가 모체혈관 내에 축적되므로 경산모일수록 그 위험률이 높아진다. 임신 중 이 Rh 항체는 언제 어떻게 발생할지 예측할 수 없으므로, 산전관리를 철저히 하여 규칙적인 혈액검사를 하는 것이 태아의 생명을 위해서 대단히 중요하다.

③ 질분비물검사

• 자궁경부세포진 도말검사

자궁경부세포진 도말검사(Pap smear)는 자궁경부와 후질원개에서 세포를 검사하여 세포성장의 비정상을 알아내기 위한 도말법이다. 환자의 이름, 나이, 분만,



주된 호소 혹은 세포표본을 취하는 이유를 양식에 기록하여 슬라이드에 첨부해야 한다. 이것들을 병리실험실에 보내어 염색, 평가하여 암세포 파위의 비정상적인 병변 유무에 대한 결과를 확인한다. 의심이 가는 질 분비물은 어느 것이나 신속히 조사해보고 모체와 태아의 건강을 위해 즉시 치료를 해야 한다.

• 분비물검사

백대하는 점액과 탈락된 질 상피세포를 포함하고 있는 정상 분비물로서, 임신 중이나 배란 시, 월경 바로 전에 질 점막의 과형성에 뒤이어 일어난다.

임신 중 흔한 질염으로는 단순질염(simple vaginitis), 트리코모나스 질염(trichomonas vaginitis), 모닐리아성 질염(monilial vaginitis) 등에 의한 비정상 분비물이 있을 수 있다.

(4) 태아사정

① 태동

태아 움직임은 16주에서 22주에 경험할 수 있으며, 이를 첫태동(quickening)이라 한다. 초산부보다 경산부는 더 일찍 경험할 수 있다.

② 태아심음

임신 12주 전후에 도플러를 이용하여 태아심음을 들을 수 있다. 보통 태아심음은 두위나 둔위인 경우는 태아 등에서, 안면위는 흉골을 통해서 가장 잘 들을 수 있다.

태아심음 청취는 임신의 확정적 징후이며, 태아의 위치 파악 및 다태임신 확인에 도움이 된다. 태아심음이 들리는 부위는 임신 20~28주에는 배꼽 바로 아래이며, 임신 30주 이후 LOA에서는 배꼽과 좌측 장골극과의 중간지점, LOP에서는 LOA보다 5cm 바깥쪽으로 떨어진 부위이다. ROA는 LOA 태위에서 잘 들리는 지점에서 중앙 오른쪽에서 잘 들리고, ROP는 옆구리 쪽에

서 잘 들린다(그림 4-I-29).

정상 태아심음은 120~160회/분으로 1분에 100회 이하나 160회 이상이면 비정상이다. 1분간 태아심음을 청취하고 심음의 규칙성 여부도 평가한다.

③ 초음파

초음파검사로 LMP 5주에서 6주에 재태낭을 발견할 수 있다. 임신 6주에서 7주에 태아심박동 청진, 임신 10주에서 11주에는 태아호흡 운동을 발견할 수 있다. 머리 엉덩이길이(crown-to-rump) 측정으로 재태연령을 사정할 수 있으며, 20주에서 30주에 측정되는 대횡경선(biparietal diameter)은 아두가 빠르게 성장하므로 재태연령을 사정하는 데 더욱 정확한 방법이 될 수 있다.

3) 추후 산전방문

임부의 개인적 요구와 위험요인을 사정하기 위해 추후 방문관리가 필요하다. 일반적으로 권고하는 산전방문 일정은 다음과 같다.

- 28주까지는 4주에 한 번씩
- 36주까지는 2주에 한 번씩
- 36주 이후부터 분만 때까지는 매주 한 번씩

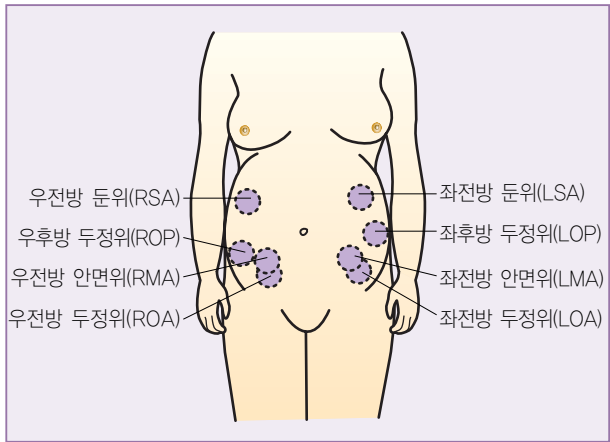


그림 4-I-29. 태향에 따른 태아심음 청취 부위

표 4-I-23. 임신 중 임상검사

검사내용	검사물	목적
소변		
• 당	• 깨끗한 소변	• 당검사 : 당뇨병 유무
• 단백질		• 단백검사 : 자간전증, 신장질환
• 현미경		• 적혈구, 백혈구, 상피세포, 미생물검사 : 신장질환, 비뇨기계 질환 유무
• 소변배양	• 깨끗한 소변	• 비뇨기계 감염을 진단
혈액		
• CBC	• 혈액	• 빈혈 유무
		• 감염, 혈액장애, 엽산결핍 확인
		• 혈액응고 기전 사정
• 매독혈청검사	• 혈청	• 매독 확인
• ABO	• 혈액	• 혈액형과 Rh+ 태아에게 올 수 있는 혈액부적합 질환을 확인
• Rh 유형	• 혈액	• 어머니가 Rh-이고 아버지가 Rh+일 때 태아위험 정도 사정(역가 상승 시)
• 풍진항체	• 혈액	• 풍진에 노출되었다면 면역 형성 여부 사정
• 알파피토프로테인	• 혈청	• 임신 15~20주 사이에 신경관 결함을 확인
• 혈당	• 혈액	• 임신성 당뇨(gestational diabetes) 확인
• 빈혈검사	• 혈액	• 혈액색소 병을 진단(검상빈혈, 지중해 빈혈)
• BUN, Creatinine, total protein	• 혈청	• 신장기능 평가, 신장질환 진단
• 간염 B 항원	• 혈청	• 간염 B 바이러스 감염
• 후천성 면역결핍증 항체 (enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA)	• 혈청	• 면역결핍 바이러스 감염
경부·질		
• 임균 배양	• 경부 분비물	• 임질진단(무증상이 혼합)
• Chlamydia 배양	• 경부 분비물	• Chlamydia trachomatis 진단
• Pap 도말검사	• 경부	• 경부 세포성장, 암, HPV, herpes 바이러스 등
기타		
• 초음파	• 자궁	• 태아 신체발달, 크기, 심장기능 등
• 융모막 융모 추출	• 융모	• 염색체 이상, 대사장애 발견
• 양수천자	• 양수	• 염색체 이상, 대사장애 발견

표 4-I-24. 임부의 혈액검사

검사 종류	검사시기	검사항목
이중표지물질 검사(double marker test)	임신 9~13주	PAPP-A, Free β -hCG
삼중표지물질 검사(triple marker test)	임신 15~20주(16~18주)	AFP, hCG, uE3
사중표지물질 검사(quad test, quadruple test)	임신 15~20주(16~18주)	triple markers+inhibin-A

표 4-I-25. 추후 산전관리 사정 지침

신체검진/정상결과	비정상 결과/ 가능한 원인	간호중재
활력징후		
체온 : 36.3~37.6℃ 맥박 : 60~90회/분 호흡 : 12~22회/분	체온상승 : 감염 맥박 상승 : 불안, 심장질환 현저한 빈호흡, 복식호흡 : 호흡질환	감염증상을 사정하고 건강관리자에게 의뢰한다. 불규칙성을 기록한다. 불안과 스트레스를 사정한다. 건강관리자에게 의뢰한다.
체중 증가		
임신 1기 : 1.6~2.3kg 임신 2기 : 5.5~6.8kg 임신 3기 : 5.5~6.8kg	불충분한 체중 증가 : 불량한 영양, 오심, 자궁내 성장 지연(IUGR) 과도한 체중 증가 : 과도한 영양섭취, 부종, 자간전증	적절한 체중 증가에 대해 논의한다. 영양상담을 제공한다. 부종이나 빈혈을 사정한다.
부종		
임신 말기의 약간의 의존성 부종	손, 얼굴, 다리의 부종 : 자간전증	부종, 혈압, 단백뇨를 확인한다. 만약 의심된다면 건강관리자에게 의뢰한다.
자궁의 크기		
정상적 변화	급격한 자궁성장 : 다태임신, 포상기태, 양수 과다증	태아상태를 사정한다. 자궁저부 높이를 측정하고 진단적 초음파를 검사한다.
태아심음		
120~160회/분	20주 이후 태아심음이 비정상적이거나 없음 : 태아건강상태 불량, 사망	태아상태를 사정한다.
임상검사		
헤모글로빈 12~16g/dl	11g/dl 이하 : 빈혈	영양 상담을 한다. 헤모글로빈은 7개월까지 평가한다.
4중 지표검사 (15~20주) 모체 혈청 α-fetoprotein, 비결합 에스트리올, hCG, 인히빈-A	MSAFP 상승 : 신경관 결손 MSAFP 감소 : 다운증후군 hCG와 인히빈-A 상승 : 다운증후군 에스트리올 상승 : 다운증후군	모든 고위험 임부에게 권고한다. : 35세 이상, 선천성 기형의 가족력, 선천성 기형아 출산 경험, 임신 전 인슐린 의존 당뇨병 4중 지표 검사에서 비정상결과인 경우 초음파, 양수 천자와 같은 정밀검사를 의뢰한다.
직접 Coomb's test(28주) Rh 음성 여성 : 음성	Rh 항체 형성 : 모체 감작	Rh 음성과 감작되지 않았다면 Rh 면역글로불린을 투여한다.
당검사(24~28주) 1시간 당내성검사	혈당 140mg/dL 이상 상승 : 임신성 당뇨병 (GDM)	GDM의 합병증에 대해 설명한다. 100g 3시간 당내성검사를 의뢰한다.
소변검사 단백 : 음성 당 : 음성 β 연쇄상구균 : 35~37주 모든 임부에게 직장 질 swab 검사	단백뇨, 알부민뇨 : 비뇨기계 감염, 자간전증	7개월에 재검사한다. 매 방문마다 재검사한다.

표 4-I-26. 임신 중 위험요인

위험요인	가능한 원인
갑작스러운 질로부터의 액체 유출	조기 양막파열(premature rupture of membranes)
질출혈	태반 조기박리(abruptio placenta) 전치태반(placenta previa) 혈성이슬(bloody show)
하복부 동통	조기진통(premature labor) 태반 조기박리(abruptio placenta)
오한과 열(38℃ 이상)	감염
현기증, 시력장애(흐릿한 시야, 복시, 암점)	고혈압, 자간전증(preeclampsia)
지속되는 구토	임신오조증(hyperemesis gravidarum)
심한 두통	고혈압, 자간전증(preeclampsia)
손, 얼굴, 다리의 부종	자간전증(preeclampsia)
근육경련, 경련	자간전증(preeclampsia), 자간증(eclampsia)
심와부 통증	자간전증(preeclampsia), 복부 대혈관의 허혈
피뇨	신부전증, 수분 섭취 부족
배뇨장애	비뇨기계 감염
태아 움직임 부재	모체 감염, 비만, 태아 사망

추후 정기검진은 추후 산전관리사정 지침(표 4-I-25)에 의해 정기적인 면담, 신체사정, 태아사정을 통해 잠재적인 합병증의 징후를 지속적으로 확인한다. 또한, 분만이 가까워져 오는 임신 후반기에는 분만의 징후를 확인하여 안전하고 건강한 분만을 준비하도록 한다.

임신 중 표 4-I-26과 같은 위험요인이 발생할 경우 즉시 건강관리자에게 보고해야 한다.

4) 임부의 사회심리적 건강사정

(1) 임신 초기

임신 진단에 관심이 많은 시기이다. 그러므로 임부는 첫 산전방문 시 흥분되고, 불안감을 나타내는 양가감정을 표시한다. 이때의 간호목표는 대상자와 의료팀 간의 신뢰감을 형성하는 일이다. 사회심리적 사정에서는 임신, 분만 경험에 대한 모성의 기대에 영향을 주는 종교·문화적 요인을 파악해야 하는데, 이는 임부가 가질

수 있는 분만에 대한 경험을 긍정적인 것으로 바꾸는데 도움이 된다.

(2) 임신 후기

주기적인 산전간호를 통해 임신, 분만에 대한 임부의 사회심리적 요구와 정서상태를 사정해야 한다. 임부와 간호사의 상호작용은 신뢰적인 분위기에서 이루어지며, 남편이 함께 참여할 때는 남편의 관심사와 요구도를 확인하는 것이 바람직하다. 이때 간호사는 임부가 질문을 하고, 관심을 표현하도록 시간을 제공하고, 관심과 이해하는 태도를 나타내며, 정보제공자로서 역할을 해야 한다. 만약 임부의 반응이 부정적이라면, 간호사는 상담을 하거나 전문가에게 의뢰해야 한다. 사정 내용은 다음과 같다.

- 임신 거부
- 스트레스 대응능력 부족

- 불안 증가
- 의사소통능력 결핍
- 부적절한 반응이나 행동
- 출산준비 계획 부족
- 음주, 흡연, 약물 남용 징후

3. 간호진단과 중재

건강력, 임신력 및 신체검진으로 수집된 자료를 사용하여 간호진단을 세운다. 임신에 대한 임부와 그 가족의 반응은 여러 가지이며, 이는 간호진단이나 중재에도 영향을 미친다. 가장 흔히 적용되는 진단은 임신에 대한 정서적, 신체적 변화, 산전기간 기대되는 것, 임신 동안의 자가간호와 가족 적응과 관련된 지식 부족이다.

건강추구행위 진단은 대부분의 임부에 적용되는 진단으로, 성공적인 임신 성취에 도움이 되는 산전간호를 배우고자 하는 요구로 임신진행에 따라 여러 가지 형태

로 나타난다. 임신 초기 임부들은 입덧을 경험하며, 이로 인하여 신체에서 요구하는 양보다 적은 양의 영양을 섭취하게 되므로 영양 변화에 대한 진단도 가능하다. 임신으로 인한 신체적 변화에 대한 불안, 임신 소실에 대한 공포, 임신 시 볼 수 있는 정서적 반응, 안전과 관련된 진단과도 연관을 지을 수 있다. 임신에 대한 가족반응과 관련된 진단으로는 가족기능변화가 있다.

임신은 흔히 스트레스원으로서의 작용이 있기 때문에 가족기능, 다양한 대처전략, 역할 재조정에 있어 출산과 신생아 간호에 필요한 계획과 준비가 필요하다. 가족의 비협조적인 행동양상, 스트레스원에 대한 비효율적인 반응과 관련된 간호진단은 비효율적인 가족대처이다. 비효율적인 가족대처에 관련된 요인으로는 정서장애, 10대 부모, 신체 질병, 경제적 곤란 등을 들 수 있다(표 4- I -27).

임신 중 관리와 교육은 모체와 태아의 안전과 건강을 목적으로 행해져야 한다. 각 임부 및 가족들의 지식수준에 알맞은 상담과 교육을 실시함으로써 임부가 두려

표 4-I-27. 임신 초기·중기에 적용되는 간호진단

시기	간호진단	원인과 관련된
임신 초기	건강추구행위(지식 부족)	•임신에 따른 정서적, 신체적 변화, 산전관리, 임신 중 자가간호, 임신에 대한 가족 적응, 각종 검사와 시술에 따른
	영양 변화 : 영양 부족	•임신 초기 오심과 구토로 인한
	불안	•임신으로 인한 신체 변화, 유산 가능성, 임신에 대한 정서적 반응, 안전에 대한 염려와 관련된
	안위 변화	•유방의 압통(민감), 하복부 동통, 임신 초기 빈뇨로 인한 불편감에 따른
	건강유지 변화	•흡연(알코올, 약물 사용)에 대한 임부 자신과 태아에 대한 지식 부족과 관련된
	가족기능 변화	•임신에 대한 가족반응과 관련된
	비효율적인 개인대처	•중독, 정서장애, 신체적 질병, 경제적 곤란, 확대가족과 관련된
임신 중기	건강추구행위(지식 부족)	•경증의 불편감 완화, 분만과 부모준비에 대한 자가간호와 관련된
	불안	•임신 후기 불편감 증가, 임박한 출산에 대한
	수면양상장애	•신체적 변화, 신체적 불편감에 따른
	활동내구성장애	•중력(신체중심) 변화, 체중 증가로 인한

움 없이 자연스러운 출산을 맞이할 수 있도록 한다. 간호사는 임신 중 활동과 안정에 관해 교육하기 전에 임부의 나이, 임부의 상태, 습관, 동기, 지식수준, 교양, 사회경제적 수준, 그 외 많은 요소들을 파악하여 임부와 좋은 관계를 유지하여야 한다. 간호사는 항상 긍정적 청취자 또는 친구로서 통찰력 있는 완벽한 지식을 갖고 임부 및 가족이 임신 중 지켜야 할 여러 가지 문제들에 관해 상세하게 설명해주어야 한다.

1) 산전관리

(1) 임부의 첫 방문 시

첫 방문 시 임신 중 모아에게 직접 영향이 될 수 있는 건강 문제를 관리한다.

- 임부, 의료진, 가족이 치료적 관계를 이룬다.
- 임부를 진찰하여 임신을 확증하고, 모체의 생식능력과 건강한 분만 가능성을 알아보며, 분만 예정일(EDC)을 예측한다.
- 임부에게 의사의 검사소견을 알리고 임부의 감정을 표현할 기회를 준다.
- 임부는 임신에 대한 자신의 결정이 자신과 가족에게 갖는 의미를 지각하고, 임신이 모체와 태아의 건강에 심각한 영향을 미친다면 임신을 계속할 것인지 유산시킬 것인지 결정한다.
- 임부의 결정에 근거하여 진료와 간호계획을 세운다.
- 진료와 간호의 평가를 포함한 기본자료를 기록한다.

(2) 임신 1, 2기(임신 14주까지, 15~26주)

① 임부의 생리반응이 정상범주인지 확인한다.

-체중 증가

제1기 : 1~2kg 또는 약간 감소

제2기 : 4.5~5kg

제3기 : 4.5~5kg

-소변검사 : 알부민은 음성이고, 포도당은 +1보다

많지 않을 경우 정상이다.

-혈압 : 정상범위이다. 임신 이전 혈압보다 수축기와 이완기 혈압이 약간 감소될 수 있다.

-부종 : 의존성 부종(dependent edema)은 흔하나 얼굴, 특히 눈꺼풀, 손에 부종이 있는 것은 비정상이다.

-자궁 : 자궁저부 높이의 점진적인 증대는 추정된 임신 주수와 일치한다.

② 태아의 생리반응이 정상범주인지 확인한다.

-태아심음(FHS) : 5~6주경에 초음파로 들을 수 있고 심박수는 120~160회/분이며, 리듬이 규칙적이다.

-태동(quickening) : 모체가 16~18주 사이에는 가끔씩, 그 후로는 계속 느낄 수 있다. 임부가 처음 느꼈던 시간을 기록해두는 것이 좋다.

③ 정서적 평가

-긍정적 정서반응과 발달과업을 나타낸다.

-비정상적인 것이 발견되면 계획을 수정한다.

④ 임신에 흔한 위험증상의 원인, 치료, 예후에 대해 알아야 한다.

⑤ 임부는 모유수유 또는 인공수유의 방법과 각각의 장·단점을 알아야 한다. 모유수유를 선택했다면 유방준비를 시작한다.

(3) 임신 3기(임신 27~40주)

① 임부의 생리반응이 정상범주인지 확인한다.

-체온 : 정상범위

-맥박 : 36주까지 8~10회/분의 점차적인 증가

-호흡 : 18~20회/분

-혈압 : 수축기와 이완기 혈압이 임신 이전 혈압에서 15mmHg보다 더 높지 않으면, 말기가 가까워지면 서 정상적으로 되며 6~10mmHg 더 높을 수 있다.

-체중 증가 : 주당 0.5kg

-소변분석 : 알부민은 없다. 포도당은 +1보다 많지 않다. 프로락틴(prolactin)호르몬이 증가함에 따라 락토오스가 존재한다.

-임부는 36주경에는 Braxton-Hick's 수축을 의식할 수 있다.

-자궁경부는 임신 말기에 가까워지면 부드러워진다.

-경임부일 경우 자궁외구가 36주경에는 3cm가량 확장되어 있다.

-초임부의 경우 태아하강이 분만 예정일 2주 전에 일어나지만, 경임부의 경우는 분만이 시작될 때까지 일어나지 않을 수도 있다.

② 태아의 생리반응이 정상범주인지 확인한다.

-예상 임신 주수에 따라 체중 증가가 있다.

-태아의 선진부와 크기가 질분만이 가능한 수준이다.

-심박동과 리듬은 정상이다(120~160회/분이며, 규칙적이다.)

③ 먼저 태어난 아이와 다른 가족의 임신에 대한 적응이 잘 된다.

④ 산전진찰은 32~36주 사이에는 매 2주마다, 36~40주 사이에는 매주 검사하며, 만약 이상상태가 발견되면 더 자주 방문한다.

⑤ 임부는 비정상적인 증세가 나타나면 누구에게 보고할 것인지, 임부가 취할 수 있는 방법에 대해 알아야 한다.

⑥ 임부는 임신 3기에 흔하게 일어나는 문제점들의 원인, 치료 및 예후에 대해 알아야 한다.

⑦ 분만준비는 임신 36주경부터 해야 한다. 임부는 분만과정과 진통형태에 대해 알고, 급박한 분만의 증세, 접촉해야 할 사람, 알려야 할 사항 등을 파악하여 병원이나 가정분만에 대해 준비를 한다.

⑧ 분만을 위한 개인기록을 완성한다.

2) 건강증진 및 유지

임신 전 기간을 통하여 임신을 질병이 아닌 건강한 시기로 인식하여 임부 스스로 자기관리를 할 수 있도록 임부를 위한 자가건강관리 능력을 증진시켜야 한다.

(1) 휴식과 수면

휴식과 수면은 건강의 기본이 되기 때문에 산전기간 동안 이 부분을 강조해야 한다. 임신 중에는 매일 밤 충분한 수면을 하고, 오전과 오후에 30분씩 잠깐 쉬든지 낮잠을 자는 것이 좋다. 휴식 시에는 다리를 높이거나 근육의 긴장을 풀고 아무것도 하지 않은 채, 편히 쉬는 것이 좋으며, 이 방법은 임신 중의 불편감을 다소 해소시킨다. 의자에 기대어서 하지를 상승시키는 자세는 다리의 부종이나 정맥류, 하지부종 등을 피하는 좋은 방법이다(그림 4-I-30). 또한 심스 체위(Sim's position)에서 둔부 아래에 베개를 받쳐서 골반을 높게 하는 것은 질이나 직장의 정맥류, 하지부종을 줄이는 데 효과적이다.

정서적 안정 역시 신체적 휴식만큼 필요하다. 여성은 임신 중 더욱 더 민감해지며, 여러 가지 면에서 정서적으로 민감하게 반응한다. 시끄러운 소리와 냄새(후각)에 민감해지고, 때로는 구역질이 나고, 미각이 변화하며, 자그마한 불쾌감에 갑작스런 화를 일으키기도 한다. 수

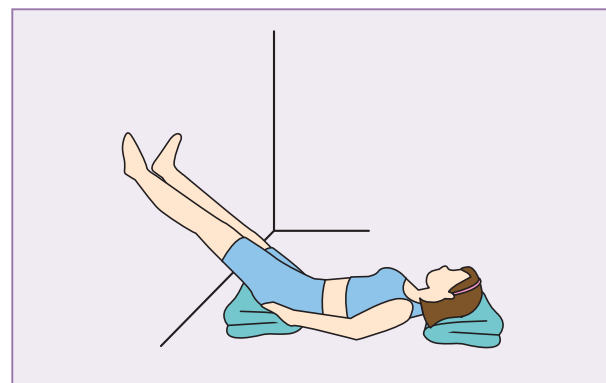


그림 4-I-30. 하지 상승

면이 문제가 될 때도 있는데, 특히 임신 초 3개월은 불면증의 원인이 되기도 한다. 해로운 수면자세는 없지만 가장 안락한 수면자세는 베개를 베고 옆으로 누워 무릎을 앞으로 뻗 상태로 자는 것이며 복부지지를 위해 베개를 사용하면 좋다.

(2) 자세와 운동

임신 동안 운동은 임부의 건강상태와 임신기간에 따라 실시한다. 운동은 기분을 전환시키고, 불안이나 긴장을 낮추고, 마음을 안정시키고, 수면이나 변비를 해결하는 데 도움이 되며, 식욕을 자극하는 등 모든 측면에서 임부 건강에 도움이 된다. 중등도의 운동은 대근육군(large muscle group)이 포함되는 걷기, 자전거 타기, 수영 등이 있다. 임부가 피해야 할 운동은 승마, 수상스키, 라켓볼, 등산, 스쿠버다이빙으로 신체 손상과 저산소증의 위험이 있기 때문이다.

임신 중 고위험상태, 즉 심장질환, 조산, 다태임신, 과거 SGA 분만, 전치태반, 출혈, 경관무력, 양막파열, 반복 유산의 경력이 있는 경우 운동을 제한하여야 한다. 심한 운동으로 인한 임부의 고온증(hyperthermia)은

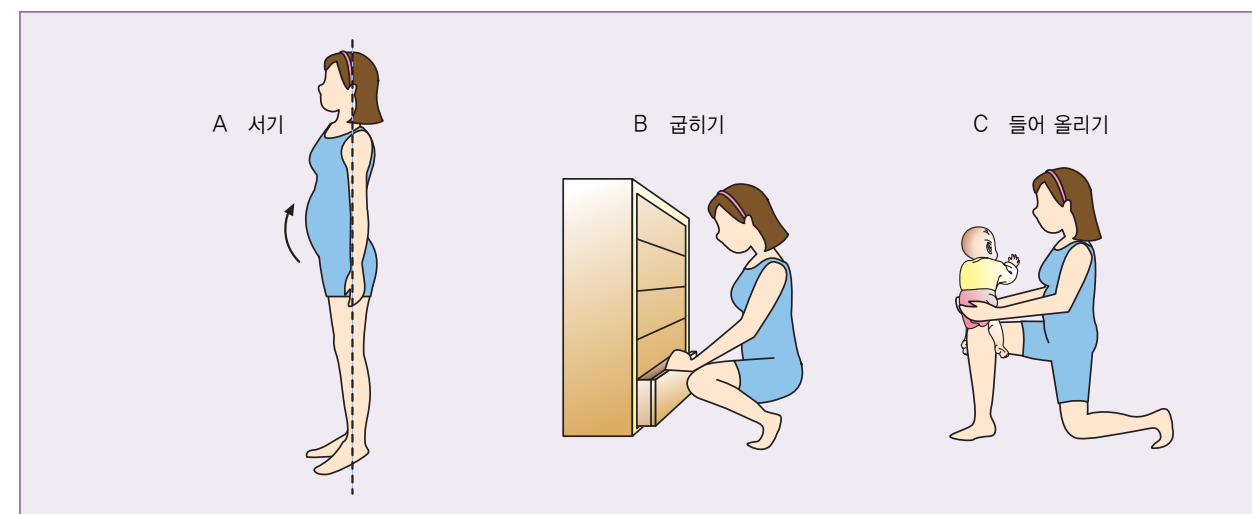


그림 4-I-31. 임부의 바른 자세

임신 초기에 효소기능에 장애를 일으켜 태아 기형을 유발할 수 있으며, 운동하는 동안 혈류는 근육으로 이동하여 자궁혈액의 감소를 가져온다. 산전운동은 복직근육의 강화, 골반근육의 이완, 대퇴근육의 신전 및 신체 각 부위를 유연하게 한다. 임신 시 올바른 자세와 운동은 다음과 같다.

① 자세

임신 중 바른 자세가 중요하다. 자세가 바르지 않을 때는 등과 목이나 머리 통증을 호소하게 된다.

• 서기

-눈높이로 서서 똑바로 앞을 보고 턱을 약간만 올린다.

-아랫배는 위로 올리는 듯, 윗배는 안으로 당기는 듯이 하여 골반을 올리는 듯한 기분으로 자세를 취하고 무릎은 약간 구부린다. 한 자세로 계속 서 있는 것은 피로감을 주므로 자주 자세를 변경하는 것이 좋다(그림 4-I-31A)

• 앉은 자세

- 의자에 앉는 경우는 등받이에 기대며 깊숙이 앉되 필요한 경우 발 받침대를 사용한다.
- 다리가 부었을 경우에는 다리를 더 높이고 앉는다.
- 바닥에 앉을 때는 다리가 겹치지 않게 책상다리를 하고 팔은 양쪽 다리에 살짝 올려 놓는다.
- 일어날 때는 엉덩이를 앞으로 끌어서 두 손으로 무릎을 짚고 일어난다.

• 눕는 자세와 일어날 때

- 옆으로 눕는 자세가 가장 바람직하다(그림 4-I-32A).
- 누울 때 무릎을 약간 구부리고 팔이나 다리 사이에 쿠션을 고이면 편안하다.
- 일어날 때는 먼저 한쪽 손으로 바닥을 짚고 몸을 일으켜 앉는다.
- 앉은 자세에서 한쪽 무릎을 세우고 무릎을 짚고 일어난다.

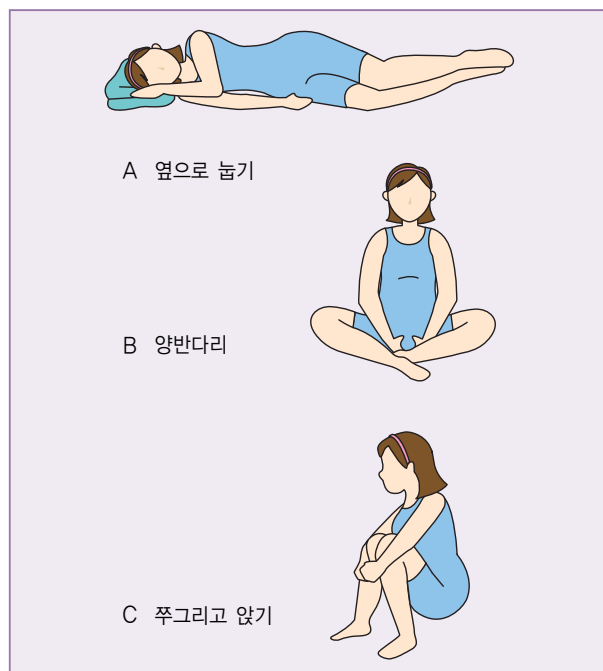


그림 4-I-32. 눕는 자세와 앉는 자세

• 물건을 들 때

- 몸무게 중심을 잘 잡아 양발을 조금 벌리고 등을 곧게 하고 앉아서 물건을 든 후 무릎을 세워 천천히 일어난다. 자세가 불안정할 때에는 의자나 그 외의 지지할 수 있는 단단한 물체를 잡고 일어난다(그림 4-I-31B, C)
- 쭉그리고 앉는 자세 : 손에 무엇을 붙잡고, 앞발을 약간 벌리면서 등을 똑바로 하고, 쭉그리고 앉으면서 옆의 물건을 잡듯이 운동을 하면 골반의 근육이 당겨져 운동이 된다(그림 4-I-32C)
- 양반다리하고 앉기 : 편안한 자세로 다리를 걸쳐 앉는다. 이 자세는 넓적다리 안쪽의 근육을 단단하게 하고 골반뼈의 관절을 튼튼하게 한다(그림 4-I-32B).
- 요가자세 : 고개를 똑바로 하고 양반다리로 앉는다(그림 4-I-33). 숨을 들이마실 때에는 두 손을 똑바로 높이 들고 두 팔을 벌리고 뒤로 내리면서 숨을 내쉰다.

② 운동

• 골반 흔들기

이 운동은 자세를 바르게 하고, 요통을 감소시키며, 배곧음근을 튼튼하게 한다. 운동을 반복하면 태아를 앞



그림 4-I-33. 이완에 적당한 자세



그림 4-I-34. 골반 흔들기

으로 향하도록 하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 태아의 혈액순환에도 도움을 준다.

- 누운 자세(그림 4-I-34A)

- 등을 바닥에 대고 똑바로 누워서 무릎을 세운다.
- 숨을 들이실 때 복부와 골반근육을 수축하고, 허리의 굴곡 부위를 바닥에 누르듯이 하면서 숨을 내뿜는다.
- 호흡이 끝난 후 몸을 이완시킨다.

- 엎드린 자세(그림 4-I-34B)

- 팔과 다리가 몸에 직각이 되게 하고, 몸무게가 손과 무릎에 균등하게 한다.
- 팔꿈치를 똑바로 펴고 다리를 약간 벌리면서 등을 똑바로 유지한다.
- 숨을 들이실 때 복부와 골반근육을 끌어당기듯 등을 C자, 즉 고양이처럼 등을 둥글게 한다.
- 고개를 뒤로 젖히면서 등을 곧게 하고 공기를 다

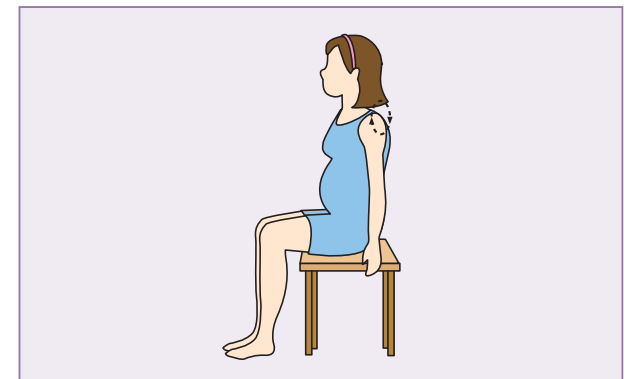


그림 4-I-35. 어깨 돌리기

내쉬면 이완한다.

• 팔을 흔들면서 몸통 돌리기

척추의 유연성을 증진시키고 가슴을 넓히며, 측복직근을 강화시키고 혈액순환을 돕는다.

- 입으로 천천히 숨을 내실 때 오른쪽 팔을 왼쪽 어깨 뒤쪽 견갑골 밑에 대고 위로 천장을 향한다. 몸통을 틀어서 고개를 오른쪽 어깨나 팔을 향하여 위로 향한다.
- 오른팔 운동을 10번 되풀이하고 잠깐 쉬 다음, 왼쪽 팔도 같은 방법으로 다시 10번 되풀이한다.

• 촛불 끄기식의 호흡

옆으로 눕거나 앉거나 설 때 손을 배에 얹고 코로 숨을 들이신 다음, 강하게 입술로 불을 끄듯이 내뿜는다. 이때 복부근육이 긴장되도록 내쉬고 들이쉬기를 반복한다.

• 어깨 돌리기

등의 상층근육을 강하게 함으로써 상부배통(upper backache), 손가락과 팔의 저림과 쿡쿡 쑤시는 것(numness, tingling)이 감소된다. 오랫동안 앉아서 일하거나, 영화를 보거나 뜨개질을 할 때 필요하다.

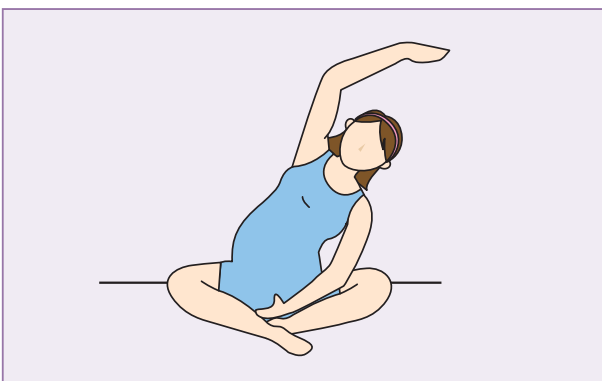


그림 4-I-36. 흉곽 들어올리기

- 팔을 옆으로 내리고 어깨를 귀 방향으로 올린다.
- 그 다음 어깨를 등으로 돌리고 잠시 쉰 다음 내려뜨리고를 반복한다(그림 4-I-35).

• 흉곽 들어 올리기

임신 후기 갈비뼈 밑의 압력을 감소시키고 숨 쉬기를 편하게 해주고 어디서나 할 수 있다.

- 왼쪽 팔을 머리 위로 올리고 오른쪽으로 할 수 있는 데까지 구부린다.
- 팔을 교대로 한다(그림 4-I-36).

• 종아리 펴기 운동

종아리에 경련을 예방할 수 있다.

- 발가락을 발등 쪽으로 잡아당기는 방법으로 종아리 근육을 늘린다.
- 다른 사람이 한쪽 손으로 발바닥을 잡고 발등 쪽으로 밀어주는 방법도 있다(그림 4-I-37).

• 다리 곧게 들기

복부와 다리의 근육을 강하게 하고 등 하부 쪽의 유연성을 높일 수 있으며 혈액순환을 돕는다.

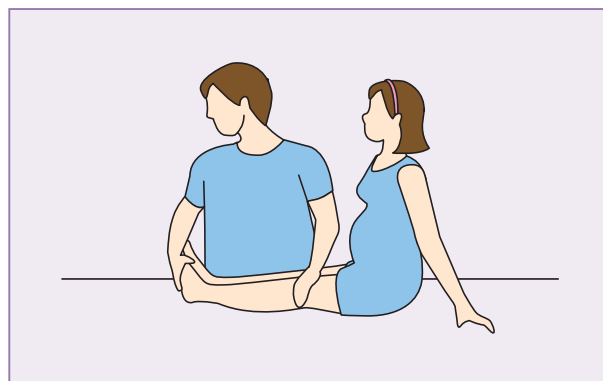


그림 4-I-37. 종아리 펴기

• 골반저근 운동

회음부를 강하게 하는 것으로 엘리베이터 운동이라고도 한다. 아기 머리가 나올 때 분만조정을 가능하게 해주는 운동일 뿐 아니라 평생 아주 중요한 운동이다. 매일 지속적으로 5~6회 실시하며, 요도, 질강, 항문 주위의 근육을 긴장, 이완시키기를 반복해야 한다.

- 소변을 보다가 잠시 중단할 때의 느낌으로 운동한다.
- 회음 부위를 수축시킬 때 회음부가 지하실에 있다고 상상하고 엘리베이터 1층, 2층, 3층으로 올라가는 것과 같이 회음부를 수축시킨다. 다시 3층, 2층, 1층으로 내려온다고 생각하고 한꺼번에 이완하지 말고 서서히 1층까지만 이완한다(그림 4-I-38).

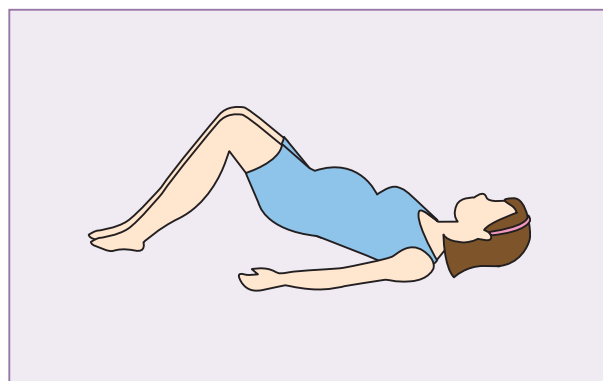


그림 4-I-38. 골반저근운동

• 어깨 움츠리기

목, 어깨 등을 이완시키며 똑바로 앉는다. 어깨를 최대한 올렸다가 뒤로, 앞으로, 밑으로 내리는 운동을 반복한다.

• 목운동

턱을 목에 대고 눈은 천장을 본 후 다시 아래를 보고, 가능한 한 고개를 많이 돌려 양 어깨를 보고, 귀가 어깨에 닿도록 양쪽으로 구부린다.

• 발목운동

의자에 앉아서 발이 바닥에 닿지 않을 때는 항상 한 발 혹은 두 발을 시계 방향으로 크게 돌린다. 이 운동은 발의 부종을 덜어주며 혈액순환을 돕는다. 또한 발가락을 코 주위에 대는 운동은 다리근육을 늘려주는 작용을 한다. 이때 베개나 담요를 받치고 하면 편리하다.

• 나비운동

가슴앓이와 호흡곤란 같은 불편감을 가진 임부에게 도움이 된다.

- 책상다리로 앉되 운동 중 허리는 반듯하게 세운다.
- 팔꿈치를 곧게 펴고 손바닥은 모두 앞으로 향하게 하여 팔을 머리 위로 올린다.
- 그 다음 손바닥을 위로 향하게 하고 팔을 곧게 뻗은 채 허리 아래까지 내렸다가 다시 어깨까지 올린다. 5회 반복한다.

• 분만대 자세 연습

이것은 분만대 위에서 다리를 벌리고 있는 것을 연습하는 것으로 대퇴 안쪽의 근육과 골반근육을 강하게 해준다, 즉 아두가 나올 때 골반근육과 대퇴 안쪽 근육이 버티고 있도록 강하게 한다(그림 4-I-39).

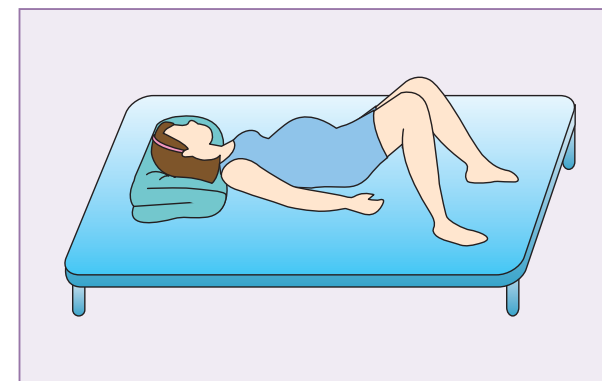


그림 4-I-39. 분만대의 자세 연습

(3) 피부 간호

임신 중에는 땀샘과 기름샘 등의 활동이 증가되어 자극이나 불쾌한 냄새가 있을 수 있으므로 자주 씻어 피부를 보호한다. 물에 압력이 가해지지 않는 한 물은 질 내로 들어가지 못하므로 임신기간 중 통목욕이 가능하지만 임부에게 적합한 목욕방법은 샤워이다. 임신 말기에는 신체의 무게중심이 변하기 때문에 외상 방지를 위해 욕조에 들어가는 것을 피하는 것이 좋고, 또한 양막파열 후에는 감염의 위험 때문에 통목욕은 금기이다.

(4) 의복

임부의 옷은 겉으로 예쁘거나 꼭 끼기보다는 실용적이고 넉넉해야 한다. 복부가 증대될 때까지 임신 전과 비슷한 옷을 입을 수 있으며, 임부복 전문 가게에서 알맞은 의복을 구입한다. 임부는 아름답게 옷을 입어 자신감을 가지도록 한다.

① 복부 지지

임신으로 인해 골반관절이 부드러워지고, 복부의 체중 증가로 자세의 변형이 와서 요통이 생길 수 있다. 만약 복부가 증대되거나 이전의 임신으로 복부가 느슨해졌다가 회복되었을 때는 잘 맞는 복대나 임부용 거들로 복부를 지지해 주고 감싸주어야 하며, 조일 필요는 없다.

② 유방 지지

모든 임부들은 잘 맞는 브래지어를 착용함으로써 유방을 적절히 지지하며, 좋은 자세를 유지하고 요통을 예방하는 데 도움을 얻는다. 브래지어는 개인의 유방 크기에 따라 잘 맞는 것을 선택하면 된다. 수유를 계획하는 임부는 임신 말기에 착용할 수 있을 뿐 아니라 산욕기 동안 아기를 수유할 때에도 사용할 수 있는 산모용 브래지어를 구입하는 것이 좋다.

③ 양말대님

동근 양말대님이나 다리를 압박하는 밴드는 정맥류를 더욱 악화시키고, 하지부종을 초래한다. 팬티스타킹이 질 분비물을 악화시키지 않는다면 착용할 수 있다. 자궁의 증대 때문에 복부정맥이 압박받으면 하지로부터 돌아오는 혈액순환이 방해받게 되는데, 동근 양말대님은 이러한 상태를 악화시킨다. 한 번 형성된 정맥류는 사라지지 않으며, 더욱 큰 문제로 이어질 수 있다.

④ 신발

복부가 커짐에 따라 임부의 자세 변화가 초래되는데, 이때 굽이 높은 구두나 신발을 신으면 상태가 악화되고 요통과 피로가 야기된다. 따라서 낮에 바쁘게 활동을 할 때나 일하는 시간에는 굽이 낮은 신발을 신는 것이 좋다. 그러나 굽 높은 신발을 착용해도 요통이 발생하지 않고, 몸의 균형을 적당히 유지할 수 있다면 약 5cm 정도 높이의 굽을 신을 수도 있다.

(5) 치아관리

태아의 치아와 뼈의 발육을 위해 필요한 칼슘을 공급할 수 있는 적당한 식사가 필요하다고 임부에게 교육해야 한다. 태아의 치아는 임신 2개월부터 발달되며, 거의 6개월까지는 영구 치아순이 형성되기 시작한다.

유전이 치아형태와 크기에 많은 영향을 미치지만 식

사와 건강, 그리고 임부의 운동 또한 매우 중요하다. 좋은 치아건강상태는 임신 시에 특히 더욱 중요하다. 치육(잇몸)은 쉽게 출혈이 되며, 붉게 변하거나 붓는 경우가 있다. 양치할 때 구역질 하는 것, 타액과다증(ptyalism), 그리고 매일의 식사습관 등은 모두 임신 시의 치아관리에 영향을 준다. 임신 초기와 임신 말기 후반에는 치과치료를 가능한 한 피하는 것이 좋으며, 적절한 치료시기는 임신 중기이다. 스케일링이 필요하면 이 시기에 하도록 한다. 치아 X선은 임신 후반기 이전에는 피하는 것이 좋다. 치아 X선검사 시에는 복부에 납치마를 하고서 얼굴 부위만 촬영을 하며, 3cm beam 장치를 써야 한다.

(6) 투약

태아에게 영향을 주는 약물 독성에 대해서 최근에 많은 연구가 이루어졌지만, 배아 기형 발생의 가능성을 지녔는지의 여부가 아직 밝혀지지 않은 약물이 많다. 특히 새로운 약물이나 약을 복합해서 쓰는 경우 기형 발생을 짐치기가 어렵다. 약으로 인해 태아에 가장 큰 형태학적 손상이 일어나는 시기는 수정에서 임신 제1기(배아시기)이다.

태반을 통과하는 주 약물은 물과 지질의 용해능력, 약

표 4-1 -28. 모체에 투여되는 약물이 태아에게 미치는 영향

모체에 투여된 약물	태아의 영향
tetracycline	다발성 골격계 이상, 뼈 성장방해, 치아탈색
thalidomide	사지, 귀, 눈, 복부장기 기형 등 비정상 상태 증가
tolbutamine(urinase)	제8신경 손상
streptomycin	제8신경 손상, 다발성 신경계 손상
methotrxate	정신적 지연
diethylstilbesterol	기능저하, 질과 경관의 분명한 세포선암, 생식계 이상

물의 분자량, 그리고 확산할 수 있는 면적에 따라 좌우된다. 모체의 신기능과 혈량이 증가하면 혈장 알부민 농도가 감소하기 때문에 단백결합능력이 저해된다. 이는 태반-태아의 약물통과를 용이하게 해 준다.

임신 중 사용하는 약물이 태아 발달에 유해한 영향을 미칠 수 있는데, 예를 들면 항생제 약물 복용과다, 항정신적 약물, 임신 중 디에틸stil베스테롤(diethylstilbesterol)을 복용한 경우 자녀가 경부암에 걸릴 수 있다고 보고되고 있다. 그 외 임신 1기에 방사선 과다노출 등도 악영향을 미친다고 알려져 있다. 이와 같이 약물 종류, 투여량, 태아의 특수한 조직발달과 연관된 시기의 약흡수가 태아의 기형을 초래하는 데 영향을 미친다. 스스로 판단하여 약물을 복용하지 말아야 하며, 치료에 쓰인 약들을 주의 깊게 기록해두는 것이 좋다.

(7) 취업

임부들이 직장생활을 계속해야 하는지에 대한 결정은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 임부의 생활형태에서 취업이 신체적으로나 정신적으로 건강과 임신을 해치고 있다면 중지되어야 하지만, 임부의 경제적, 심리적인 경우에 따라 상황이 각각 달라질 수 있다. 임신한 여성 중에 많은 경우 집안에 있기를 싫어하고 또한 경제적인 문제 때문에 쉬지 못할 수 있다. 따라서 그들의 직업과 봉급은 상당히 중요하며, 대다수의 여성들은 임신 후에도 그들의 직장에 계속 다니기를 원하며 아기가 태어나면 직장생활에서의 잠정적인 휴식 또는 휴직 정도만을 원하고 있다. 오늘날 많은 기업들은 임신한 직원들에 대한 제약을 많이 없애고 있으며 특히 우리나라 모성보호법에 따라 정해진 법 테두리 안에서 보호받을 수 있다. 직장을 가진 임부는 신체적, 정신적 부담이 동료들에게 나쁜 영향을 미치게 되지 않도록 의식해야 하며, 모체와 태아에 미치는 영향에도 신경을 써야 한다.

다음의 내용들은 직장을 가진 임부가 이상적으로 행

동해야 할 사항들이다.

- ① 신체적 무리를 하지 말 것. 그리고 피로할 때까지 일하지 말 것
- ② 물건을 운반하는 데 임부에게 적합한 방법으로 옮길 것
- ③ 해독물질을 다루는 직업을 피할 것
- ④ 집이나 직장에서 적절한 휴식을 취할 것
- ⑤ 의사가 지정한 노동의 한계를 지킬 것

일반적으로 오랜 시간의 노동은 피해야 하는데 오랜 시간의 노동이란 장시간 서 있다든지 앉아 있는 것이며, 야간근무, 무거운 것을 운반하는 것, 신체균형의 감각을 요구하는 업무 등은 피해야 한다. 임부는 쉽게 피로해지며, 또한 일상적인 에너지 수준으로의 빠른 회복이 불가능하다. 따라서 집에서나 회사에서나 임부에게는 일한 후 항상 휴식이 필요하며, 10분 정도라도 다리를 높게 하고 누워 있으면 에너지가 다소 보충된다. 조산이나 유산 가능성이 있는 여성은 휴식이 필수적이므로 시간제 직업으로 변환하거나 일을 중단해야 한다.

(8) 예방접종

임부를 위한 면역과 예방접종은 매우 중요하다. 많은 바이러스들이 태반의 경계막에 침투하여 태아에 감염될 수 있다. 따라서 임신 중에는 모든 생균을 약화한 바이러스 접종, 즉 홍역, 이하선염, 풍진(MMR), 구강용 소아마비(sarbin 백신), 수두 등의 예방접종은 피해야 한다. 그러나 인플루엔자 예방접종과 파상풍 예방접종은 가능하며, 또한 여행을 하게 되는 경우 감염성 질환을 예방하기 위해 의사와 상의하는 것이 필요하다.

(9) 여행

임신 중에는 집에서 멀리 여행하지 않는 것이 좋으나 여행이 필요하다면 기차 또는 비행기로 여행하는 것이 좋다. 기차는 임부 승객을 태우는 데 아무런 제약조건

이 없다. 비행기 여행은 임신 초기인 태아형성시기에 있어서 위험스런 태아 저산소증의 가능성이 있으나 기압장치가 잘된 비행기에서는 위험성이 별로 없다. 국내선과 국제 비행기의 제약조건은 각기 상이하여 어떤 경우에는 탑승 전에 산전관리 의사의 소견 등의 서류를 제출해야 하는 경우도 있다. 임부들은 하루에 무리하게 모든 여행을 끝마치지 않도록 주의해야 한다. 150~250km당 휴식이 필요하며, 이 휴식은 몸이 굳어 짐과 경련, 혈액순환장애를 방지해준다. 여행에서의 휴식은 차를 잠깐 세워서 밖에 나가서 주위를 잠시 걷는 다든지, 발을 높이 올려놓는 것 등을 의미한다.

(10) 운전

임신 말기 3개월 동안에는 밤에 혼자 운전하는 것을 피해야 하며, 또한 사람이 살지 않는 곳을 운전하는 것을 피해야 한다. 운전 시마다 안전벨트를 사용하며 안전벨트의 어깨띠는 유방 사이, 골반띠는 자궁하부를 가로지르도록 해 복부에 압력을 주지 않는 안전한 위치에 매어야 한다(그림 4-I-40).

(11) 수유 준비 및 유방 간호

모든 여성은 자신의 아기에게 수유하는 것이 바람직하다. 모유수유를 통해 맺을 수 있는 아기와 의 좋은 관계와 아기와 엄마에 대한 모유수유의 이로운 점을 설명해주면 많은 여성이 수유에 성공적인 결과를 가져올 수 있다. 모유수유를 준비하기 위해서 유방마사지를 적절히 하는 것은 매우 필요하다(그림 4-I-41)(모유수유 참조).

모유수유를 하고자 하는 여성은 집기검사(pinch test)를 통해 유두의 유형(함몰, 편평, 정상)을 확인한다. 함몰형 유두인 경우는 특별히 임신 5~6개월부터 간호를 시작할 수 있으며, 더 일찍 시작하는 것은 효과적이지 않다.



그림 4-I-40. 임부의 안전벨트 착용법

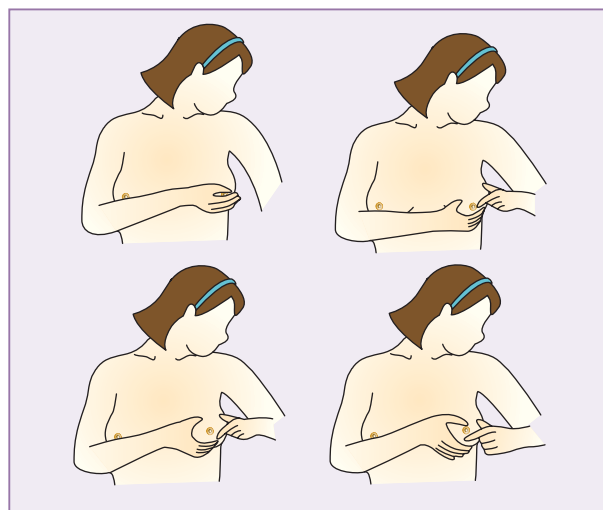


그림 4-I-41. 유방 마사지

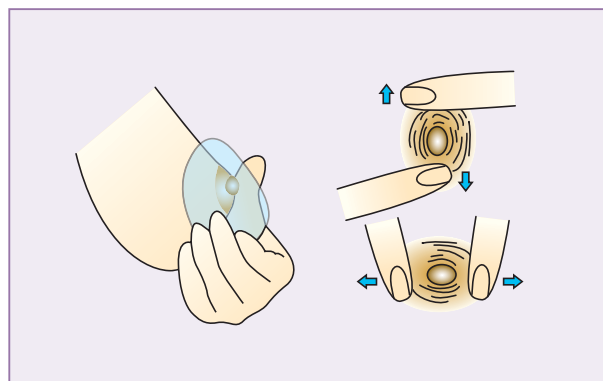


그림 4-I-42. 함몰유두 관리

임부의 유두가 편평하거나 함몰된 경우에는 유두를 교정하기 위한 조치를 하여야 한다. 유두 덮개(nipple shield)를 브래지어 안에 착용하면 유두 주위에 압력을 가하여 유두를 잡아당기기 쉽게 된다. 유두 덮개는 매일 시간을 늘려가며 착용할 수 있다. 또 유두 양 옆의 유륜을 검지손가락을 사용하여 서로 반대편으로 잡아당겨 유두가 돌출되게 하며(Hoffman법)(그림 4-I-42) 유두가 잡을 수 있을 정도로 돌출되면 유두 잡아당기기 와 굴리기를 한다. 이 과정은 수유를 시작하는 초기까지 계속해야 한다.

(12) 성생활

과거에는 전체 임신 기간인 9개월 동안 성생활이 금지되었으나, 오늘날에는 파막되거나 출혈이 있거나 유산의 두려움이 있을 때만 금지한다. 계속적으로 유산을 경험한 임부에게는 어느 기간 동안 성교를 금지시킨다. 의사, 간호사와 임부 사이에 성생활에 관한 대화는 중요하다. 임부는 이런 질문에 대답을 피하려 한다. 간호사가 여성이라면 임부와 의 대화가 가능하며, 임부가 부끄럽거나 몰라서 또는 문화적 요인 때문에 대답을 못하는 경우엔 민첩하게 대처해야 한다. 잘못된 정보는 말을 막히게 하고 대화 시 오해를 야기시킨다. 임부가 불안함을 느끼거나 성교를 원하지 않거나 극치감이 자궁수축을 유발시킬 수 있다고 생각될 때는 성행위를 하지 않는 것이 좋다.

(13) 질세척

임신 동안 회음부의 피지선 활동이 활발해지므로, 어떤 여성들에게서는 불쾌하고 독특한 냄새가 나기도 한다. 보통 비누와 물로 닦아도 이러한 냄새를 없애는 데 효과적이다. 또한 심각한 질감염이 있지 않는 한 샤워만으로도 청결함을 유지할 수 있다. 그러나 질염이 있는 경우에는 의사와 상의해야 한다.

표 4-I-29. 흡연이 모체와 태아에 미치는 영향

모체	태아
니코틴 중독	저체중
혈관 수축	사산
카테콜라민 증가	SIDS(태아돌연사증후군)
심혈관계	선천적 기형
비타민과 무기질 대사방해	알레르기
태반 기능부전	호흡기질환
모유로의 오염	성장장애, 지적 능력과 언어장애

(14) 임부의 흡연 및 음주

① 흡연

흡연이 미치는 생리적 영향 중 가장 많이 연구되어 있는 것은 니코틴(nicotine)이다. 니코틴은 흡연 시에 즉각 폐로 흡수되며, 혈중 니코틴 수준은 흡연의 기간과 강도, 흡연의 양, 담배의 종류, 필터의 유무에 따라 다르다. 흡연 시 니코틴은 혈관 수축과 산소결합능력의 감소와 더불어 갈슘, 인을 포함한 무기질, 비타민, 호르몬, 포도당, 지방산 및 아미노산대사를 방해한다. 이러한 영양소의 흡수장애는 모체의 영양상태뿐 아니라 태아에게도 영향을 미친다(표 4-I-29).

② 음주

음주와 임신과의 관계는 1900년 전부터 밝혀져 왔다. 1968년 처음으로 음주 여성의 아기에서 증상이 보고되

표 4-I-30. 음주가 모체와 태아에 미치는 영향

모체	태아
알코올중독	저체중아
탄수화물, 지방, 단백질 대사 방해	세포성장과 분화 방해
자연유산	비특이성 기형
태반기형과 기능부전	FAS(태아 알코올증후군)
• 저체중아	
• 태반 조기박리, 전치태반	

었고, 1973년 태아 알코올증후군(fetal alcohol syndrome, FAS)이 밝혀졌는데, 이는 산전산후 성장결핍과 발달지연, 정신박약, 소뇌증, 미세운동기능부전, 그리고 심한 음주의 경우 얼굴 기형을 일으킬 수 있다.

FAS를 야기시킬 수 있는 최소한의 음주량을 정확히 알 수는 없으나 에탄올(ethanol)과 그 대사산물이 배아와 태아의 성장발달을 변화시킬 수 있다. 지속적인 연구를 통하여 태아 알코올 효과(fetal alcohol effects)와 알코올과 관련된 출생 시 손상(alcohol-related birth defects, ARBD) 등이 구체적으로 밝혀지고 있다(표 4-I-30).

3) 임신 동안의 영양관리

임신 중 적절한 체중증가는 전반적인 측면에서 성공적인 임신에 크게 기여한다. 체중이 지나치게 증가하면(기준에 135%보다 많을 경우) 출산 후 그대로 남게 되고 고혈압, 당뇨, 맥관계 장애와 같은 만성질환이 발생하기 쉽다. 임신 중 영양상담은 질적인 음식 섭취와 불필요한 체중 증가를 피하여 중년 이후의 건강 위험이 최소가 되도록 해야 한다.

(1) 체중 증가와 태아건강

임신 2,3기 체중 증가는 태아성장에 있어 특히 중요하다. 적절하지 않은 체중 증가는 자궁강 내 성장지연(IUGR)일 수 있고, 한편 지나친 체중 증가는 아두골반 불균형이 되어 수술분만, 출산 시 태아손상, 저산소증

(asphyxia)이 될 수 있다.

임신 중 체중 증가와 태아성장 사이의 관계는 임부의 임신 전 체중에 따라 다르며, 신체체질량지수(body mass index, BMI)를 기준으로 평가한다. 즉 BMI는 체중과 신장을 측정한 후 체중값을 신장으로 나눈 체질량지수($BMI = \text{kg/m}^2$)로, BMI 결과 19.8 이하는 저체중, 19.8~26은 정상 체중, 26~29는 약간 과체중, 29 이상은 매우 과체중으로 해석한다(표 4-I-31).

(2) 체중 증가 양상

체중과 신장이 표준인 경우(BMI 19.8~26) 권장되는 체중 증가는 다음과 같다. 임신 1기 동안 1~2kg, 임신 2, 3기에는 1주에 0.4kg씩 증가하는 것이 좋다. 임신 2기에는 모체 성장, 3기에는 대개 태아 성장이 이루어진다.

정규적인 산전방문 시 체중을 사정하고 건강상태를 확인해야 하는데, 지나친 체중 증가인 경우 수분축적일 수 있으며, 특히 임신 20주 후 한 달 3kg 이상의 증가는 임신성 고혈압(pregnancy induced hypertension)이 의심된다. 임신 중 체중감량을 위한 식이요법을 해서는 안 되는데 특히 마른 여성인 경우(BMI<19.8) 태반에 영양공급이 적절치 않으면 태아성장지연이 있게 된다(그림 4-I-43). 과체중인(BMI>26~29) 경우는 임신 전에 체중조절을 계획해야 한다.

임신 중에 영양에 대한 교육은 임부에게 우유를 마시

표 4-I-31. 정상임부의 바람직한 체중 증가 범위

임신 전 상태	키에 대한 임신 시 체중	BMI	Lb	kg
저체중	바람직한 체중의 90% ↓	19.8 ↓	28~40	12.5~18
정상 체중	바람직한 체중의 90~120%	19.8~26	25~35	11.5~16
약간 과체중	바람직한 체중의 121~135%	26~29	15~25	7~11.5
매우 과체중	바람직한 체중의 135% ↑	29 ↑	15 ↑	7 ↑
전체 증가			15~40	7~18

(3) 임신 중 필요한 칼로리와 영양소

임부의 영양상태는 건강한 성숙아를 분만하는 데 직접적인 영향이 있다. 영양상태가 나쁜 것은 저체중 신생아 출산과 관련되며 저체중 신생아는 사망률이 높고 정신박약이나 기타 다른 장애를 가지기 쉽다. 그러므로 임신 동안 영양상태에 관하여 임부들에게 교육, 상담을 하는 것이 매우 중요하다.

① 열량

임신 중 태아 조직의 성장과 모체 조직의 요구량을 유지하기 위해서 에너지를 필요로 한다. 음식물의 에너지는 kcal로 표시하는데, 임신 중에는 비임신 시보다 300cal가 부수적으로 더 필요하게 된다. 300cal는 태아와 태반조직이 자라는 데, 분만 후 수유를 위해, 임부의 기초신진대사(BMR) 증가와 활동하는 데 쓰인다. 또한 적당량의 칼로리는 단백질이 조직을 형성하고 임부의 몸에 저장되기 위하여 필요하다. 만일 칼로리가 부족하면 단백질이 에너지로 쓰이게 된다.

적당량의 체중 증가는 성공적인 출산을 위해 매우 중요하다. 3가지의 중요한 요인들은 체중 증가의 총량, 체중 증가의 유형, 체중 증가에 기인한 식사의 성분이나 질 등이다. 임신 중 평균 체중 증가는 약 11kg(24Lb)에 달한다. 체중 증가의 유형은 체중 증가의 총량보다 더 중요하다(그림 4-I-44).

체중이 모자라는 임부는 체중이 많이 나가는 임부보다 임신성 고혈압에 걸릴 위험이 높다. 또한 임신 제2기 동안 체중 증가가 안 되면 임신성 고혈압이 발병할 확

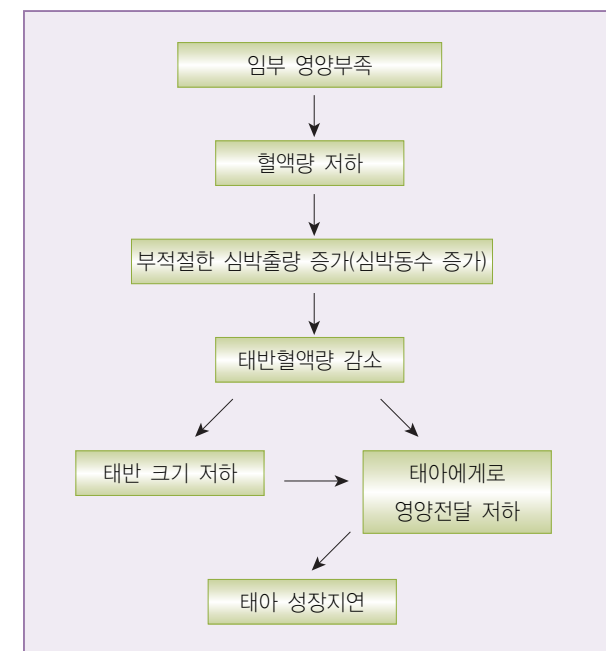


그림 4-I-43. 영양과 태아성장과의 관계

면 된다고 가르치는 것처럼 단순할 수도 있고, 태아의 발달에서 영양학의 과학적 기초를 이해해야 할 만큼 어렵기도 하다. 지극히 간단한 것부터 복잡한 영양문제에 이르기까지 임부들을 도울 수 있는 지식과 이해가 필요하며, 임신 중 영양의 중요성에 대한 과학적 근거를 제시함으로써 임부의 영양에 관하여 최선을 다해야 한다.

수태부터 출생 때까지 태아는 모체로부터 필요한 여러 물질을 섭취하게 되므로, 모체의 충분한 칼로리 섭취는 임신합병증이 적고 건강한 아이를 낳게 한다.

표 4-I-32. 생식주기에 있어서 영양이 나쁠 때 일어날 수 있는 문제

• 불임 • 생식 상해(태아 상해) • 유산 • 사산 • 신생아 사망	• 임신 문제 • 자간전증, 자간 • 태반이상 • 임신성 당뇨 • 분만 곤란	• 저체중 신생아 • 모체의 산욕회복지연 • 수유곤란 • 신생아 정신·신체발달 지연
--	--	---

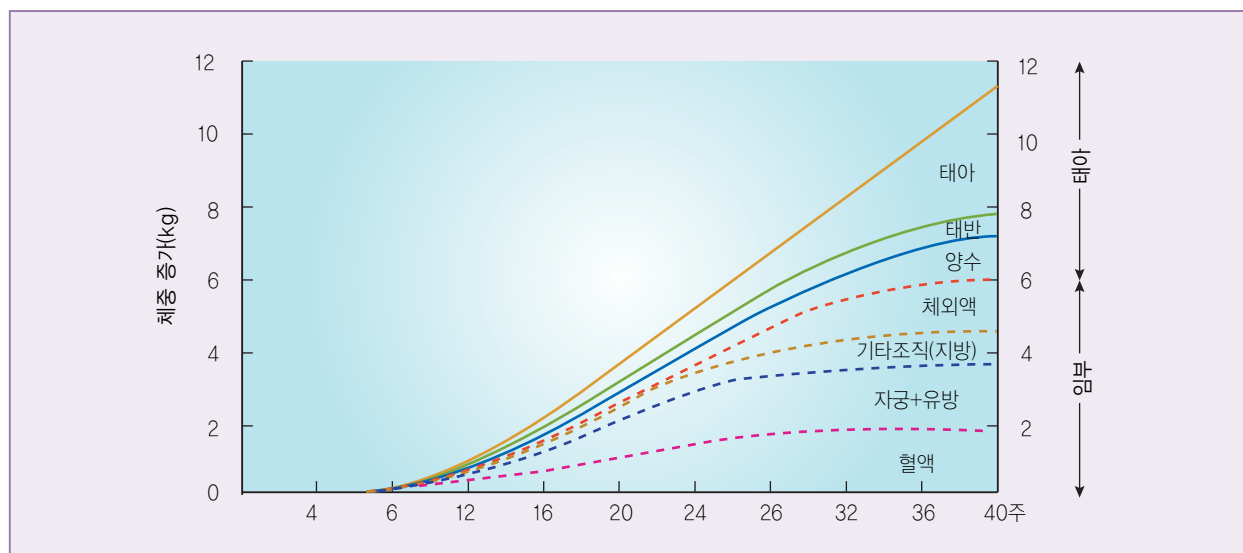


그림 4-1-44. 임신기간에 따른 체중 증가

물이 높으며 태아가 정상보다 작거나 미성숙아가 된다고 한다. 극도로 체중이 모자라는 임부가 임신 마지막 몇 주 동안 체중이 4.2~4.5kg까지 늘면 임신성 고혈압에 걸릴 확률이 낮아진다.

에너지 생산을 하는 주된 영양소는 탄수화물이며 과일, 야채, 곡물에 포함되어 있다. 지방 또한 농축된 에너지원으로 탄수화물보다 두 배 이상의 열량을 가지고 있다. 임신이 진행되면서 점점 더 많은 글루코오스가 태아의 성장을 위하여 사용되기 때문에 모체 측 에너지원으로 사용되는 지방의 분해가 증가한다. 에너지를 공급하는 것 이외에 식품 속에 함유되어 있는 지방은 필수지방산을 제공하며, 지용성 비타민 A·D·E·K의 운반과 공급을 담당한다.

② 단백질

단백질은 임신 중에 태아 발달이나 모체 혈액의 증가, 유선과 자궁조직 등 모체조직의 증가를 위해 아미노산과 질소를 공급한다. 단백질 결핍은 비정상적 출혈의 빈도를 증가시키고 저혈소판, 저능아를 유발한다.

단백질 권장량은 임신 전보다 하루 14g 이상 증가하

여 60g의 단백질을 섭취하는 것이 필요하다. 단백질은 20가지 이상의 아미노산이 결합되어 형성되는데 이들 중 8가지는 체내에서 합성될 수 없기 때문에 필수아미노산이라고 부르며 이들은 식품을 통해서만 공급되며 동물성 단백질식품들이 여기에 포함하며, 식물성 단백질 식품들은 이들 중 한두 가지 혹은 그 이상의 필수아미노산이 결핍되어 있는 상태다.

정상적인 비임신 여성의 매일 단백질 허용치는 46g이며, 임신여성의 1일 단백질 허용치는 76g, 활동적인 여성은 매일 100g 이상으로 증가된다.

모든 필수아미노산을 내포한 양질의 단백질은 우유, 고기, 달걀, 치즈에 많다. 단백질이 풍부한 음식에는 칼슘, 철분, 비타민 B도 함유되어 있다.

③ 무기질

• 칼슘과 인

임부는 태아의 뼈와 치아 형성, 에너지와 조직성장, 임부 자신의 계속적인 필요를 위해 부수적인 칼슘과 인의 섭취가 필요하다. 임부와 수유부는 하루 1,000mg의 칼슘 섭취가 필요하다. 만일 칼슘의 섭취가 부족하면

표 4-1-33. 철분제 복용을 위한 임부교육

- 비타민 C(감귤류 과일, 토마토, 멜론, 딸기) 및 heme 철분(육류)은 철분보충제의 흡수를 증가시키므로 식이에 자주 포함시킨다.
- 겨(ban), 차, 커피, 우유, 수산염(oxalate: 시금치 뿌리에 포함), 달걀노른자는 철분 흡수를 저하시키므로 철분보충제와 동시에 복용하지 않는다.
- 철분은 공복에 복용할 때 가장 흡수가 잘되므로 식사와 식사 중간에 차, 커피, 우유를 제외한 음료와 함께 복용한다.
- 식간에 복용하여 복통이 있으면 취침 전에 복용할 수 있다.
- 복용을 잊었을 경우 복용했어야 할 시간 13시간 이내면 가능한 한 빨리 복용하고, 다음 복용시간에 2배로 복용하지 않는다.
- 어린이가 열지 못하는 용기에 철분보충제를 두고 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 철분 때문에 변이 검거나 진한 녹색이 될 수 있다.
- 철분 보충제로 인해 변비가 흔하므로 섬유질과 적절한 수분 섭취가 필요하다.

태아에게 필요한 칼슘은 모체 골격이 용해되어 충족될 것이다. 우유 1L에 칼슘이 1,200mg이 함유되어 있으므로 우유 섭취를 통해 칼슘 요구량을 충족시킬 수 있다.

• 마그네슘

마그네슘은 뼈의 중요한 구성성분이며, 모든 살아 있는 세포에서 발견된다. 이 원소는 세포산화, 단백질, 지질대사, DNA와 RNA에 필요한 효소의 활동에 중요하다.

• 철분

임부의 철분 섭취 증가가 필요한 이유는 증가된 적혈구에 헤모글로빈을 공급하기 위해, 태반을 위해, 태아의 헤모글로빈, 미오글로빈, 많은 효소들의 합성을 위해, 임신 후반기 동안 태아의 철분 저장을 위해, 영유아기에 혈액의 손실을 보충하기 위해 필요하다. 임부의 철분 저장량과 식사에 포함된 철분은 이러한 필요를 충족시키는 근원이다. 그렇지만 상당수의 여성은 철분 저장량이 부족하거나, 전혀 철분이 저장되어 있지 않은 상태로 임신하는 경우가 있다. 가임기의 여성은 매일 18mg의 철분 섭취가 적당하다. 이 양은 여성에 있어 매일의 요구를 충족시키고, 임신에 필요한 철분을 저축할 수 있는 양이지만 18mg 철분은 일반적인 식사에서 쉽게 얻어질 수 있는 양이 아니다. 식사 때 섭취하는 철분

과 모체의 철분 저장량은 임신 중의 요구량을 충족하기에는 일반적으로 부족하기 때문에, 모든 임부는 입덧이 사라진 후 임신 2기부터 하루에 30~60mg의 철분제 복용을 시작하는 것이 바람직하다. 임부를 위한 철분제 복용에 대한 중요성을 강조하여야 하며, 자가간호교육이 필요하다(표 4-1-33).

• 엽분

엽분은 체액균형을 조절하고 신진대사를 위해 필수적이다. 엽분의 필요량은 모체조직의 확장과 태아의 요구 때문에 임신 기간 중 필요하게 된다. 엽분의 권장량은 2~3g이 적절하다. 그러므로 엽분을 무분별하게 제한하는 것은 오히려 해롭지만, 지나친 엽분이 포함된 음식, 예를 들어 감자칩, 햄, 소시지 등의 과다한 섭취는 피하는 것이 좋다. 임부의 전체적인 혈액순환량이 적절할 때 신장과 태아에게로 가는 혈액량도 적절해진다. 만약에 엽분의 섭취가 부족하면 순환량이 저하되어 모체와 태아에게 상해를 주게 된다. 그러므로 건강한 임부인 경우 임신이라 해서 특별히 신경써 먹어야 된다는 건강관리방법은 재고할 여지가 있고 모체의 입맛에 맞게 섭취하는 것이 오히려 타당하다고 본다.

• 아연

아연은 DNA와 RNA 합성과 단백질대사에 관련되고

대부분이 신진대사 경로에 관여하는 효소들의 구성원이다. 수유기 동안 유즙생산과 태아 성장발달을 위해 필수적인 영양소이기도 하다. 임부의 하루 권장량은 12mg이다. 임부에게서 아연이 결핍되면 태아의 선천성 기형, 지연분만과 관련되며 양수에 박테리아성 감염 빈도를 증가시켜 조산을 일으키기도 한다.

• 요오드

요오드는 모든 체내의 조직에 존재하는 티록신(thyroxine)의 필수요소이다. 티록신은 정상적인 신진대사와 성장에 필수적이며 요오드 부족은 갑상샘비대증을 유발한다. 임부의 권장량은 요오드염을 통해 220mcg 정도이다. 유아와 어린아이에게 있어서 요오드 결핍은 갑상샘기능저하증, 크레틴병 혹은 점액수종을 일으키며, 육체적 성장과 정신적 성장지연을 유발하기도 한다. 염분을 제한하는 경우에는 의사의 처방하에 요오드약물을 처방할 수 있다.

④ 비타민

비타민은 생명 유지에 필수적이며, 매일 소량씩 식품을 통하여 공급되어야 한다. 비타민은 탄수화물, 단백질, 지방 등의 대사작용에 직접적으로 관여하고, 신체의 조절반응이 유지되도록 돕는 작용을 한다. 신체 내의 많은 반응들은 한 가지 이상의 비타민을 요구하며 한 가지 비타민의 결핍은 또 다른 기능을 방해할 수 있으며, 대부분의 비타민은 신체 내에서 합성되지 않는다.

• 지용성 비타민

임신 중에 비타민 A를 지나치게 복용한 경우 신생아 기형이 나타나므로 임신 중에 비타민 A 보충제는 피해야 한다.

모든 성장기에 있는 사람과 임부에게는 400IU의 비타민 D가 적당하다. 자외선에 피부가 노출되면 충분한

양의 비타민 D를 합성할 수 있다. 장기간 비타민 D 과다섭취(2,000IU 정도, 즉 하루 필요량의 5배 정도)는 과칼슘혈증이나 신석회증을 일으킨다.

• 수용성 비타민

엽산은 세포분열과 단백질 합성에 필요한 DNA, RNA 합성에 필수적인 수용성 비타민이다. 엽산은 백혈구와 적혈구의 생성과 아미노산의 대사에 관여하고 그 세포분열에 필수적이기 때문에 태아의 성장을 위해 꼭 필요하고, 임신 중에 특히 중요하다.

임신 전에 엽산 보충이 안 된 경우 신경관 결손(neural tube defects, NTDs)과 관련이 있다. 엽산 보충제는 임신 전과 임신 6주 이전에 복용하는 것이 보다 효과적이다. 임부의 엽산 권장량은 600mcg이며, 이 양은 비임부보다 50% 정도 더 섭취해야 하는 양이다. 연구결과 임신 중에는 엽산 필요량이 급격히 증가하므로 하루 3회의 식사로 임신기간 필요량을 충족시키기는 어렵다. 그러므로 임부는 하루에 400mcg의 엽산정을 추가로 먹는 것이 바람직하다.

⑤ 물

여성은 매일 평균 6~8잔을 섭취하여야 하고, 물과 우스가 가장 좋다. 일부 음료수는 식품첨가제를 함유하고 있어 임신 동안에는 삼간다.

또한 일부 음료수는 당 성분을 많이 함유하고 있으며 영양음료는 인공적인 감미료를 많이 포함하고 있고, 콜라, 차, 커피는 카페인을 많이 함유하고 있으므로 과량 섭취하지 않는 것이 좋다.

(4) 영양학적인 면에서 간호사의 역할

영양공급을 간호사의 임무로 인식한 것은 나이팅게일 이후부터였다. 간호사는 임부의 영양관리를 위하여 영양상담을 주재하며, 영양학적인 문제를 다루는 교육팀

에 참여하고, 임부와 상담 중 전문 영양상담이 필요한 경우 영양사에게 의뢰해야 한다.

① 영양상담자로서의 간호사

영양상담은 임부에게 무엇을 먹어야 하고, 왜 먹어야 하는지를 가르쳐주는 것만이 전문가 아니다. 영양상담의 주된 목표는 식사에 대한 임부의 현재 문제를 찾아내어 해결책을 제시하고 임부가 영양에 대해 생각하고 느끼는 바를 듣고 영양에 대해 올바른 결정을 하도록 하며, 식사의 질을 향상시키고, 음식의 영양소와 영양가에 대해 알려주고 식사습관을 고치도록 유도하고 도와주는 것이다. 따라서 영양상담에 임부의 참여와 협조는 매우 중요하다.

② 상담의 필요조건

- 매일 먹어야 하는 음식이 영양학적으로 얼마나 유용한가를 알려주어야 한다.
- 일상적으로 섭취하는 음식의 영양가에 대한 지식이 필요하다.
- 하루 식사량에서 영양가를 높이는 것이 중요하며 질적인 향상이 있어야 한다.
- 영양소의 기능을 알고 이것을 임부에게 설명해주는 능력이 필요하다.
- 음식의 영양가를 나타내주는 도표나 임신 중 영양 필요량 증가를 나타내주는 도표 같은 교육도구가 필요하다.
- 임부들이 식단을 변화시키도록 실질적인 제시를 하는 것이 필요하다. 간호사는 영양사로부터 어떻게 문제를 해결하는가를 물어 도움을 얻을 수 있다.
- 간호사는 음식에 대한 특별한 지식을 알아야 하고, 특별한 문화권에 속하는 사람들의 신념에 대해서도 알 필요가 있다.

③ 영양상담의 단계

- 임부와 관계를 정립한다. 임부에게 상담의 목적은 영양에 관한 것이고, 임부가 먹는 것이 자신의 건강과 태아의 건강에 중요하다는 것을 설명한다. 가능하다면 남편이 상담에 참석하는 것이 좋은데, 부인의 식사의 중요성을 이해하는 데 도움이 되며 관심을 가져 식사를 개선하는 데 앞장설 수 있기 때문이다.
- 임부가 어느 정도 알고 있으며, 임신 중에 어떻게 느끼고 있고, 임부가 가지고 있는 문제가 무엇인가를 파악한다. 대부분의 임부는 메스꺼움, 입덧, 가스, 다리 저림, 음식 알레르기, 갈증에 대해 호소한다. 임부는 영양소의 기능과 음식의 영양가에 대해 어느 정도 지식을 가지고 있다. 간호사는 식사 습관에 대해 임부에게 정보를 구하기 전에, 질문에 대답을 하고 문제해결을 제시해주어야 한다.
- 임부가 무엇을 먹는가를 결정하는 데는 식사기록 방법이나 식사 대화기법이 사용되는데, 식사기록 방법은 임부에게 집에서 먹은 것을 묻고 평소에 먹는 것을 기록한다. 임부가 대기실에 기다리고 있는 동안 식사기록을 작성하는 것이 바람직하다. 식사 대화기법은 단순히 임부에게 전달 무엇을 먹었는가와 평소에 무엇을 먹는가를 질문하는 것이다. 주말이나 공휴일의 식사는 일상적인 것이 아니므로 질문에서 피하는 것이 좋다. 임부는 간호사가 식사 정보를 기록하는 동안 기록되는 내용을 보면서 이 상담에 좀 더 친밀하게 참가할 수 있다.
- 임부에게 식사의 중요성을 강조한다. 임부를 옆에 앉히고 간호사와 임부가 같이 기본적인 음식(우유, 육류, 과일, 야채, 곡물)의 섭취 종류를 세어본다. 다음은 필요량과 섭취한 양을 비교하여 본다. 그러면 임부는 식사에 무엇이 더 필요한가를 알 수 있다. 이러한 식사 변화는 임부의 차트에 기록하여 중

요한 부분에 줄을 친다. 이러한 과정은 도표를 개인화해야 하며, 임부에게 영양의 필요성을 고취시킬 수 있다. 이때 간호사는 임부에게 왜 식사의 개선이

필요한가를 질문해보는 것이 좋다. 간호사는 다음 단계를 시작하기 전에 임부가 식사 개선의 중요성을 충분히 인식하고 있는가를 검토해야 한다.

표 4-1 -34. 한국인 임부의 영양권장량(한국영양학회, 2010)

영양소 (단위)	비임부 권장량 (19~29세)	임부 권장량 (임신 2기)	임신과 관련된 역할	음식공급원
열량(kcal)	2,100	+340	태아와 태반조직 성장, 모유생성, 임부의 기초신진대사(BMR) 증가와 활동	탄수화물, 지방, 단백질
단백질(g)	50	+15	태아 발달, 모체조직 증가(유산과 자궁의 조직, 양수), 모체 혈류량 증가, 수유 시 유 단백질 분비	우유, 고기, 달걀, 치즈, 요구르트, 콩류, 견과류, 곡류
무기질 칼슘(mg)	1,000	1,000	태아의 뼈와 치아형성, 에너지와 조직 성장, 임부의 뼈와 치아	우유, 치즈, 요구르트, 정어리 및 기타, 뼈째 먹는 생선, 시금치와 진녹색 채소, 칼슘 함유 두부
마그네슘(mg)	340	+40	뼈의 구성, 세포산화, 단백질, 지질대사, DNA와 RNA에 필요한 효소의 활동	견과류, 콩과 식물, 코코아, 고기류, 전곡류
철분(mg)	14	+10	임부 헤모글로빈 생성, 태아의 간에 철분 저장	간, 고기류, 전곡류, 강화된 빵, 시리얼, 진녹색 채소
아연(mg)	8	+2.5	DNA와 RNA 합성과 단백질 대사와 관련, 효소 구성성분, 부족 시 태아 중추신경계 기형과 관련	간, 조개, 고기류, 전곡류, 우유
요오드(mcg)	150	+90	임부의 신진대사 증가 관련	요오드 추가 소금, 해산물, 우유와 유제품, 효소 함유 빵, 도넛
지용성 비타민 A(mcg)	650	+70	눈, 피부의 상피세포와 소화기, 비뇨생식기, 점막세포의 기능 유지, 정상 연골세포의 발달	진녹색 채소, 진황색 채소, 과일, 적고추, 간, 강화된 마가린과 버터
D(mcg)	5	+5	칼슘과 인 흡수에 관여, 무기질 침착 증가	강화된 우유와 마가린, 달걀노른자, 버터, 간, 해산물
E(mcg)	10	10	항산화제, 특히 적혈구 파괴 예방에 중요	식물성 기름, 녹색잎 채소, 전곡류, 간, 견과류와 씨, 치즈, 어류
수용성 비타민 C(mg)	100	+10	조직형성, 철분 흡수 촉진, 골격, 치아, 콜라겐 형성	오렌지류 과일, 딸기, 멜론, 브로콜리, 토마토, 피망, 진녹색 잎채소
엽산(mcg)	400	+200	임부의 적혈구 생성, DNA, RNA 합성에 필수적, 신경관 기형 예방	강화된 시리얼, 브로콜리, 아스파라거스, 시금치와 같은 녹색 잎채소, 콩류
B ₁₂ (mg)	2.0	2.2	핵산과 단백질 생성, 특히 적혈구 형성과 신경계 기능 중요	우유와 유제품, 달걀, 고기류, 간, 강화된 두유

(3) 요통

요통은 임부의 자세가 변화되어 오는 것이다. 좀 더 나은 자세(등을 강화하기 위해 골반을 앞으로, 태아를 밑으로 기울인다). 운동, 5cm 뒤축이 있는 구두, 딱딱한 매트리스, 휴식, 진통제 등이 유용하다.

(4) 유방의 아픔

임신기간 동안 유선통을 예방하려면 브래지어는 넓고, 늘어나지 않고, 끈이 달린, 잘 맞고 지지력 있는 것을 사용하는 것이 효과적이다. 일시적으로 고통을 덜려면 시원한 습포가 효과적이며 따뜻한 물로 위생적으로 닦는다. 연고제와 크림 사용은 불필요하며 오히려 피부염을 일으키기도 한다.

(5) 두통

임신 동안에는 긴장하여 두통이 잘 일어난다. 보통 감정적이나 육체적인 스트레스가 원인이 되며, 설명, 안심, 이완을 시켜주는 것이 유익하다. 두통의 원인, 예를 들면 부비동염(sinusitis), 눈의 피로, 신경학적 문제는 치료해야 한다.

(6) 오심과 구토

오심은 임신 초기 동안 임부 대부분이 경험하는 것으로 변화된 호르몬의 양과 대사변화가 원인이다. 긴장하고 양가감정을 갖는 여성이 이러한 문제를 잘 겪는데, 하루 중 어느 때나 일어날 수 있다. 때때로 심한 구토(임신오조, hyperemesis gravidarum)로 진행된다. 임신 시 오심과 구토가 있을 때는 염분이 없는 탄수화물 크래커, 토스트 또는 팝콘을 아침에 일어나기 전에 먹는 것이 좋고 입에 맞는 소화되기 쉬운 음식을 조금 먹는 것이 좋다. 비위에 거슬리는 냄새를 피하고 안심을 시켜주며 일반적인 지지방법을 쓰는 것이 좋다. 위장장애의 다른 이유인 식중독이나 감염성 질환일 수도 있으므로

- 임부에게 어떻게 식사를 변화시키고 어떻게 만들려고 하는가를 물어보고, 임부가 이 문제에 대해 생각하고 대답할 시간을 충분히 준다. 임부는 이 문제를 혼자서 해결하고 식사 개선을 결정하는 것이 바람직하다. 만일 임부가 문제를 해결하는 데 어려움이 있다면 간호사가 암시를 줄 수도 있다.
- 간호사는 임부에게 만일 새로운 문제가 생기거나 계획을 수행할 수 없으면 또 찾아오라고 알려주어야 한다. 만일 문제가 빈혈, 변비, 당뇨 혹은 다른 병일 때 부수적인 상담이 요구된다. 식사 개선이 제대로 되지 않았다면 간호사는 이유를 찾아내고 조언을 해야 한다.

4) 임신 중 경증 불편감

(1) 복부팽만

복부의 불편감(드물게는 통증)은 자궁이 증대됨으로써 나타난다. 서 있거나 걸을 때는 무거운 느낌이나 자궁의 무게를 느끼게 되지만 눕거나 이완자세를 취하고, 자주 쉬면 완화된다. 다태임신으로 복부가 과다팽만되었을 때에는 임부용 거들(maternity girdle)을 이용하면 불편감을 덜 수 있다.

(2) 자궁수축

무통성이고 불규칙적인 수축은 정상적인 것이다. 그러나 때때로 날카로운 자통(twinge)이 임신 말기에 발생할 수 있으며, 특히 조용히 있거나 누워 있을 때 일어난다. 이때에는 휴식을 취하고, 자세를 변경시킨다. 분만 중 자궁의 근육이나 인대의 긴장을 감소시키려면 옆으로 눕거나 앉은 자세에서 손과 팔을 밀어서 편안한 자세를 취하도록 한다.

요로감염이나 충수염, 부속기의 뒤틀림(torsion of adnexa), 장폐색 같은 염증성 질병은 복부의 통증을 일으킬 수 있는 다른 원인들이므로 의사와 상담한다.

로 이를 고려해야 한다.

(7) 현기증

현기증은 보통 맥관운동의 불안정이나 자세에 따른 저혈압에 의한 것으로 임부에게 흔한 증상이다. 덥고 땀나는 곳에서 갑자기 자세를 바꾸는 경우 이러한 불유쾌한 느낌을 촉진시킬 수 있으나 실신(syncope)까지

나타나는 경우는 드물다. 천천히 움직이는 운동, 시원한 환경, 탄력성 있는 긴 양말의 착용 등이 도움이 된다. 심한 경우 저혈당 혹은 신경학적 질병도 고려해야 한다.

(8) 가슴앓이

가슴앓이는 위 식도역류(gastroesophageal regur-

표 4-1-35. 임신 중 경증 불편감에 대한 완화요법

불편감	생리	간호
임신 1기		
유방 변화	• 유선조직 비대와 호르몬 자극 • 유륜 착색, 유두 증가	• 따뜻한 물로 씻는다. • 임부용 브래지어를 착용하여 적절하게 유방을 지지한다.
빈뇨	• 자궁증대로 방광용적 감소 • 호르몬으로 방광기능 변화	• 골반저근운동을 한다.
오심, 구토 (morning sickness)	• 융모생식샘자극호르몬(hCG)의 증가 • 대사변화 • 정서적 요인 • 4~6주 출현, 12주까지 지속	• 공복과 과식을 피한다. • 일어나기 전 마른 탄수화물 식이, 따뜻한 차를 마신다. • 소량씩 자주 식사한다. • 자극적인 식이, 가스 생성 음식, 튀긴 음식, 임부가 좋아하지 않는 음식은 피한다. • 갑작스런 자세변경을 피한다. • 심리적 지지를 한다.
타액과다 (ptyalism)	• 에스트로겐 분비 증가	• 수렴제로 구강을 청결히 한다. • 츄잉검을 씹는다.
치욕염	• 에스트로겐에 의한 맥관 증식	• 충분한 단백질과 과일을 섭취한다. • 부드러운 칫솔을 사용한다.
심리적 변화	• 호르몬과 대사변화, 여성 역할	• 가족과 배우자가 정서적으로 지지한다.
코막힘(비출혈)	• 에스트로겐 상승으로 점막출혈	• 생리식염수로 비점적한다. • 가습기를 사용한다.
백대하	• 경부비후, 점액량 증가	• 질세척은 금한다 • 화음패드를 사용한다. • 기본적인 회음 위생간호를 한다. • 팬티스타킹은 피한다.
피로	• 대사율 증가, 에너지 부족 • 사회심리적 원인	• 규칙적인 운동을 한다. • 충분한 수면과 휴식을 취한다. • 균형식이를 취한다.

<계속>

표 4-1-35. 임신 중 경증 불편감에 대한 완화요법

불편감	생리	간호
임신 2기		
심계항진	• 원인불명	• 예방할 수 없다. • 안정 및 지속적으로 관찰한다.
체위성 저혈압	• 양와위 시 자궁 무게로 인한 상행성 대정맥 압박	• 측와위, 무릎을 구부린 반좌위를 취한다.
가슴앓이(heartburn)	• 프로게스테론 영향 : 위의 분문 괄약근 이완, 위식도 역류, 연동운동 지연 • 자궁압박으로 위 상승 • 임신 말기에 심함 : 자궁증대로 위와 십이지장의 위치 상승 • 증상 : 역류, 트림, 식도압박	• 가스형성, 자극적 식이, 지방성 식이, 과식을 제한한다. • 상체를 반듯하게 자세를 유지한다. • 우유를 조금씩 섭취한다(일시적 완화). • 나비운동을 한다. • 필요시 처방하에 제산제를 투여한다. • 여유 있는 옷을 입는다. • 하루에 물 6~8잔을 섭취한다.
변비	• 프로게스테론의 영향 : 위장관의 이완, 연동운동 감소 • 철분 섭취제 복용 • 증대된 자궁압박	• 충분한 수분을 섭취한다. • 규칙적인 운동을 한다. • 규칙적인 배변습관을 갖는다. • 섬유질 식이를 섭취한다. • 관장은 피한다. • 미네랄 오일 복용을 금지한다(지용성 비타민 흡수 방해).
정맥류	• 임신 중 혈액량의 증가 • 커진 자궁의 압력으로 인한 외음부, 항문 주위의 정맥류 야기 • 임신 동안 해소되지 않으며 분만 후 없어지기는 하나 완전히 없어지지 않음	• 비만, 장시간 앉아 있는 것, 조이는 의복, 변비를 피한다. • 탄력스타킹을 착용한다. • 하지를 상승시킨다. • 다리 꼬는 자세는 피한다. • 자주 걷는다. • 굽이 낮고 편안한 구두를 신는다.
손가락의 주기적인 마비와 쭈뼛	• 상완신경총 긴장증후군(brachial plex traction syndrome)	• 좋은 자세를 유지한다. • 분만 후 소실된다.
관절통, 요통, 골반중압감	• 프로게스테론 영향 • 커지는 자궁에 대한 보상으로 척추만곡, 근육신장, 무게중심의 변화	• 임부용 거들을 착용한다. • 좋은 자세를 유지한다. • 굽이 5cm 이하인 신발을 신는다. • 규칙적인 운동을 한다(산전운동, 요가). • 무거운 물건을 들지 않는다. • 국소 열찜질을 적용한다. • 적절한 체중 증가를 유지한다.
두통	• 증가된 순환 혈액량과 심박동으로 인한 뇌동맥 이완, 팽창 • 피로와 정서적 긴장 • 임신성 고혈압과 구별	• 이완운동을 한다. • 규칙적인 식사를 한다. • 두통을 야기할 수 있는 일은 피한다. • 처방 없이 약을 복용하지 않도록 교육한다.

<계속>

표 4-1-35. 임신 중 경증 불편감에 대한 완화요법

불편감	생리	간호
임신 3기		
짧은 호흡과 호흡곤란	• 자궁증대에 의한 횡격막 확장 제한 : 하강감 후 완화	• 좋은 자세를 유지한다.
불면증	• 태아 움직임, 근육경련, 빈뇨	• 의식적 이완을 한다. • 마사지, 온수목욕을 한다.
정서적 반응	• 호르몬과 신진대사 • 출산과 부모 역할에 대한 감정	• 가족과 배우자의 지지가 필요하다.
빈뇨와 요절박감	• 아두하강으로 인한 방광압박	• 골반저근운동을 한다. • 회음패드를 한다. • 취침 전 수분을 제한한다.
회음부 불편감과 압박감	• 자궁증대, 다태임신	• 휴식, 의식적 이완, 임부용 거들
하지경련	• 칼슘과 인의 불균형 상태 • 피로와 근육의 긴장 • 자궁증대에 의한 신경압박	• 경련이 발생한 근육을 신장시킨다. • 탄산칼슘이나 유산칼슘을 경구 투여한다. • albuminum hydroxide gel을 경구 투여하여 인을 배출시킨다. • 국소 열찜질을 적용한다. • 취침 전 따뜻한 물로 목욕한다. • 규칙적으로 운동한다.
발목 부종	• 장기간 서 있거나 나쁜 자세 • 운동 부족 • 수분정체	• 휴식 시 하루에 2~3회 20분 동안 하지를 상승시킨다. • 충분한 단백질을 섭취한다. • 염분은 정상적인 양을 섭취한다. • 오래 서 있는 것을 피한다. • 이뇨제 사용을 금지한다.

gitation)의 증세이다. 임신 초기 긴장, 오심, 구토와 연관되어 나타날 수도 있으며 임신 말기에는 자궁증대로 인한 위장의 위치 변화로 야기된다. 음식이나 액체가 위를 잘 통과하기 위해서 글루타민산 hydrochloride 같은 네오스티그민(장운동 촉진제)이나 산성화 물질을 복용한다. 뜨거운 차를 마시거나 껌을 씹는 것도 도움이 된다. 식사 사이에 alminum hydroxide gel 제제 같은 제산제를 쓰는 것도 좋으나 중탄산소다 제제는 피해야 한다. 지속적인 증상을 보이는 환자는 식도 열공 헤르니아(hiatus hernia)나 소화성 궤양(peptic ulcer)인지 확인해야 한다.

(9) 치질

치질은 항문 주위의 정맥류이다. 고통스럽고, 골반 내 울혈이 생기면 종종 출혈이 되기도 한다. 변비와 배변시 힘을 줄 때 또는 분만 제2기 동안 힘을 주는 것에 의해 치질이 생긴다. 보통 분만 후에는 염증이 감소되므로 보존요법이 좋다. 배변습관을 규칙화하고 변기 위에서 편안한 자세를 취하도록 하며 변 완화제, 좌약, 그리고 경한 변 완화제를 처방할 수 있다. 치질절제술이나 주사약은 감염의 위험이나 골반 내 정맥들의 혈전증 때문에 임신 중 금기로 되어 있다.

(10) 변비

빈약한 음식물 섭취, 수분 섭취의 부족, 나쁜 배변습관, 철분 보충제 섭취 등이 다른 때와 마찬가지로 임신 중 변비의 원인이 된다. 치질이나 다발성 게실증은 변비로 인해 가중될 수 있다. 장폐색 같은 내인성 장 문제는 보통 통증이 심하며, 지속되는 질병이 아니다. 좋은 배변습관, 충분한 양의 음식물 섭취, 섬유질이 많은 과일과 야채의 섭취, 적당한 운동, 충분한 수분 섭취를 하는 것이 좋다. 변 완화제를 처방할 수는 있으나, 관장을 하거나 완화제를 오래 쓰는 것은 금기이다.

(11) 하지경련

장딴지, 허벅지 또는 둔부 근육에 갑작스런 경련이 수면 중에 잘 생길 수 있다. 다리의 경련은 칼슘 섭취 부족이나 자궁증대로 인한 골반신경과 혈관의 압박, 피로, 오한, 긴장, 칼슘과 인의 불균형 때문에 발생한다. 하지 경련은 주로 임신 제1기와 마지막 달에 일어나며, 칼슘 섭취량을 증가시키고 유산칼슘 0.6g을 하루 3번 식전에 투여하는 것이 좋다. 과량의 인 섭취는 한 끼 정도 식사를 제한하고, 매일 500ml 정도의 우유를 마심으로써 막을 수 있다. 식사 때마다 aluminum hydroxide 1g을 경구 투여하여 인을 배출하도록 한다.

(12) 발목 부종

임신 말기 대부분의 여성들이 발목과 하지의 부종을 겪는다. 부종은 오래 앉아 있거나 서 있는 것 또는 더운

날씨에 의해 증가된다. 혈압이나 단백뇨 없이 하지 부종만 있으면 절박한 자간전증의 징후는 아니다. 환자에게 다리와 둔부를 올린 상태로 앉거나 누워서 휴식시간을 갖게 하고, 꼭 끼는 양말 대님의 착용을 피하며, 일어나기 전에 지지용 양말을 신고, 염분이 많은 음식은 피하고 고단백식을 충분히 섭취하는 것으로 대부분 완화된다.

(13) 빈뇨와 긴급요의

빈뇨와 긴급요의는 거의 모든 임부에서 임신 초기와 말기에 특히 많이 나타난다. 요도 감염의 다른 증상이 없으면 안심시키고 골반저근운동을 하여 회음부의 근육을 강화한다. 실금에 대비하여 회음패드를 하는 것도 가능한 방법의 하나이다.

(14) 정맥류

정맥류는 보통 나이 든 다산부나 근육 긴장력이 떨어지는 비만 임부에게 문제가 된다. 정맥류는 유전적 경향이 있음이 알려졌다. 심한 정맥류가 다리나 외음에 나타날 수 있고, 종종 다리의 동통이나 압통(aching of leg and tenderness)을 일으킨다. 분만 후에는 혈액응고가 증가하여 혈전증으로 발전될 수 있다. 낮 동안에는 탄력성 있는 지지용 양말을 신고, 밤에는 풀어 혈액순환을 도우며, 몸에 꼭 끼는 옷의 착용을 금한다. 임신 기간 정맥류에 대한 혈관수술이나 주사치료는 패혈증의 가능성 때문에 피해야 하며, 수술을 한다 해도 측부 순환이 발달되어 치료가 실패할 수 있다.

관련 사례

23세의 주부인 김○○씨는 G1, P0으로 8주째 초임부이다. 아침에 일어날 때 속이 메스꺼워 구토하려고 화장실에 몇 번 씩 들락날락하지만 구토 내용물은 없고 물 같은 분비물만 조금 뱉어낼 뿐이라고 호소하였다. 아침밥을 거의 먹을 수가 없고 점심이나 저녁은 먹을 수 있다고 한다. 하복부통증이나 질출혈, 질 분비물은 없으며 심장과 폐는 정상이다. 복부검진은 정상이며 골반검진에서는 외부생식기가 병소 없이 깨끗하였으며 경부는 닫혀 있고 전체적으로는 건강해보인다. 열은 없고 혈압은 100/70mmHg, 맥박은 78회/분, 호흡횟수는 16회/분, 체온은 37℃이다.

1. 위의 사례에서 가장 우선적으로 사정해야 할 내용을 설명하시오.
2. 위의 사례에서 가장 우선적으로 해야 할 간호 중재를 설명하시오.

핵심 문제

1. 김○○씨는 산전간호를 받기 위해 병원을 방문하였다. 마지막 월경이 3월 26일에 시작하여 3월 31일에 끝났다고 답변하였다. 김○○씨의 분만 예정일은 언제인지 계산해 보시오.
2. 김○○씨는 산전간호를 받기 위해 병원에 첫 방문하였다. 쌍둥이를 조산하였고 만삭아를 1명 분만하였으며 1회 유산한 경험이 있다. 현재 임신 8주인 김○○씨의 산과력 표기방법을 설명하시오.

임부의 간호과정

사정	잠재적 간호진단	계획/수행	평가
임부의 생리적 상태 : 활력증상, 체중, 소변, 자궁 저부 높이, 태아심박동수, 활동, 증상, 검사결과	지식 부족 : 임신이 신체에 미치는 영향과 관 련된 태의 성장발육과 관련된	• 전반적인 건강력, 산과력, 신체검 진 및 각종 검사를 산전관리 시 받도록 하고 재방문 시 계속 관 리한다.	• 임부는 분만 예정일을 확인하였다. • 임부는 경증 건강 문제와 합병증 을 이해하였다.
임부의 사회심리적 상태 : 임신에 대한 반응, 가족의 적응, 사회심리적 영향에 대 한 지식	지식 부족 : 임신이 사회심리적 영역에 미치 는 영향과 관련된 자아존중감 장애 : 임신이 신체사회심리양상에 미치 는 영향과 관련된	• 임신에 대한 태도, 지식수준, 임신 에 대한 기대, 가족과 개인의 자 원, 대처기전, 경제적 상황에 대해 논의를 한다.	• 임부는 임신에 대한 기대감을 이 야기했다. • 임부를 지지해줄 사람을 알아두 었다. • 임부는 정보를 확실하게 이해하고 있었다.
건강유지요구도 : 자가간호, 식이, 휴식, 운동, 투약, 성생활	지식 부족 : 임신 시 영양적 요구량과 관련된 흡연, 음주, 약물의 위험과 관련된 임신 시 성생활과 관련된 건강유지장애 : 증가된 정신신체적 요구와 관련된	• 임신기간 동안 건강과 안위를 유지하는 방법에 대한 정보를 제공한다(휴식, 운동, 일, 오락, 여행, 투약, 면역, 피부간호, 유 방간호, 의복, 치아, 배변습관, 질세척, 흡연) • 성관계, 약물, 목욕, 음주에 대해 교육한다. • 특별한 문제가 발생되면 의료인 이나 대리인에게 위탁한다.	• 임부는 부족한 영양소를 채우는 방법을 말하였다. • 임부는 성생활이 가능한 점을 받 아들었다. • 임부는 휴식시간을 따로 갖게 되 었다.
경증의 불편감 : 특정한 장기에 대한 증상 비뇨생식기, 위장관, 비뇨기, 근골격계, 신경계	안위변화 : 오심구토, 가슴앓이, 변비, 두통, 치질, 고장, 요통, 호흡곤란, 하지 경련, 질 분비물과 관련된 활동내구성 장애 : 피로, 호흡곤란과 관련된 질감염 위험 : 호르몬 변화와 관련된	• 빈뇨, 오심구토, 가슴앓이, 변비, 팽만감, 치질, 요통, 호흡곤란, 정 맥염, 하지경련, 질분비물 등의 불 편감에 대한 정보나 지식을 제공 한다. • 불편감이 일상생활에 방해가 되 거나 계속되면 의사나 다른 의료 인에게 의뢰한다.	• 임부는 불편감이 감소되었다고 말 하였다. • 임부는 증상에 대한 치료법에 관 심을 나타냈다. • 임부는 치료함으로써 편안함을 경 험하였다. • 임부는 지시를 계속적으로 따른다.
부모가 되는 데 대한 준비성 : 임신 시 영양, 태아발육, 산 전관리, 분만과 아기간호 준 비 등에 대한 지식 정도	지식 부족 : 태아 성장발육과 관련된 임신으로 인한 신체적 변화와 관 련된 임신으로 인한 심리사회적 변화 와 관련된 출산준비자원과 관련된	• 태아성장과 발육에 대하여 설명 한다. • 임신과정, 신체적, 정서적 변화, 산전관리, 출산준비 및 교육적 서 비스를 제공하는 자원 등에 대한 정보와 지식을 제공한다(어머니 교실, 영양사)	• 부부는 산전교실에 참석하였다. • 부부는 태아발육, 임신영양, 산전 관리를 이해하였다고 말했다. • 부부는 출산을 위한 계획을 세 웠다. • 부부는 퇴원 후 아기간호 계획을 세웠다.
임신험병증 징후 : 혈압 상승, 안면부종, 출혈, 과다체중, 임신 주수에 비해 비정상적인 자궁저부 높이	고위험임신험병증 : 구체적인 증상과 관련된 불안, 공포 : 임신험병증과 관련된	• 부가적인 신체검진 자료를 조사 한다. • 필요한 검사를 한다. • 임부에게 증상과 징후의 의미를 설명한다. • 앞으로의 간호계획을 설명한다.	• 임부는 합병증의 원인을 이해하 였다. • 임부는 불안이 감소되었다고 말하 였다.
사회심리적 문제 징후 : 불이행, 어린이 같은 행동, 힘들다고 표현함 자신이 아이의 엄마가 맞는 지 의문을 나타냄	자아존중감장애 : 임신, 기타 일상생활 변화와 관 련된 부모 역할 또는 가족으로의 과정 변화 : 사회심리적 문제와 관련된	• 문제와 원인을 확인한다. • 사회경제적, 문화적 불균형 문제 를 위해 지역사회자원을 이용하 도록 한다. • 건강 문제에 맞는 건강요원이나 다른 기관에 의뢰한다.	• 임부는 자신이 엄마임을 알게 되 었다고 말하였다. • 임부는 도움이 되었다고 말하였다. • 임부는 문제가 개선되었다고 말하 였다.

